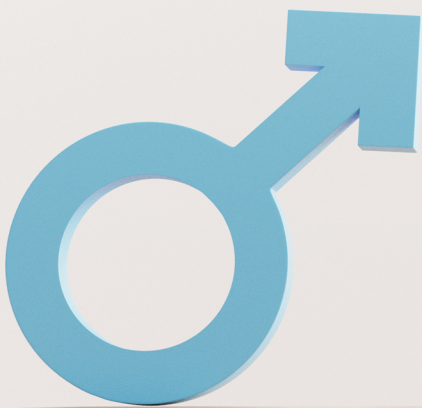


Bunga Rampai

KESETARAAN GENDER DALAM PELAYANAN KEBIDANAN IMPLIKASI TERHADAP SIKLUS HIDUP PEREMPUAN

Meidayana Refisiliyani
Muliana
Ngatemi

Editor: Kursih Sulastriningsih



BUNGA RAMPAI
KESETARAAN GENDER DALAM PELAYANAN KEBIDANAN:
IMPLIKASI TERHADAP SIKLUS HIDUP PEREMPUAN

Penulis:

Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb.

Bd. Muliana, S.Tr.Keb., M.K.M.

Ngatemi, S.SiT., MKM.

Editor:

Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, SsiT., M.Kes.



Bunga Rampai Kesetaraan Gender dalam Pelayanan Kebidanan: Implikasi terhadap Siklus Hidup Perempuan

Penulis: Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bd. Muliana, S.Tr.Keb., M.K.M.
Ngatemi, S.Si.T., MKM.

Editor: Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, SsiT., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7426-07-9

Cetakan Pertama: Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku ***Bunga Rampai Kesetaraan Gender dalam Pelayanan Kebidanan: Implikasi terhadap Siklus Hidup Perempuan*** kami hadirkan sebagai upaya memperkuat praktik kebidanan yang berperspektif kesetaraan, berpusat pada perempuan, peka budaya, dan berbasis bukti. Bunga rampai ini memandang kesetaraan gender bukan sekadar wacana, tetapi prasyarat mutu layanan, keselamatan pasien, dan pemenuhan hak kesehatan pada setiap fase kehidupan perempuan dari remaja, kehamilan dan persalinan, hingga lansia. Oleh karena itu, naskah disusun untuk menjembatani konsep, kebijakan, dan praktik di lapangan agar dapat diadopsi pada pelayanan primer, rumah sakit, dan komunitas.

Struktur buku mengikuti alur siklus hidup. **Bab 1** (Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb.) menegaskan landasan konseptual kesetaraan gender, dinamika perkembangan remaja perempuan, isu-isu kunci dan hak remaja, faktor yang memengaruhi capaian kesetaraan, hingga strategi praktis dan peran remaja perempuan sebagai agen perubahan. **Bab 2** (Bd. Muliana, S.Tr.Keb., M.K.M.) mengupas kesetaraan gender dalam kehamilan dan persalinan—mulai konsep hingga dampak ketidaksetaraan pada keselamatan ibu dan bayi, kerangka kebijakan dan regulasi, strategi serta intervensi, juga studi kasus dan praktik baik untuk memperkuat asuhan yang menghormati martabat dan otonomi perempuan.

Menutup rangkaian, **Bab 3** (Ngatemi, S.Si.T., MKM.) memfokuskan kesetaraan pada perempuan lansia: peran sosial yang berubah, akses terhadap layanan kesehatan, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi, serta tantangan budaya dan stigma. Bab ini menawarkan jalur pemberdayaan, peran keluarga–masyarakat–pemerintah, dan peluang inovasi serta teknologi untuk memperkecil kesenjangan. Setiap bab dilengkapi **kesimpulan, referensi, dan glosarium**, serta diakhiri **profil penulis** agar pembaca mudah menelusuri basis ilmiah dan rekam jejak kontributor. Semoga buku ini menjadi panduan aplikatif bagi pendidik, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan kebidanan yang setara, aman, dan bermartabat sepanjang siklus hidup perempuan.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KESETARAAN GENDER PADA REMAJA PEREMPUAN..... 1

Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb. 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Kesejahteraan Gender.....	2
C. Remaja Perempuan Dan Perkembangannya.....	4
D. Isu-Isu Gender pada Remaja Perempuan.....	7
E. Hak-Hak Remaja Perempuan.....	8
F. Faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender pada Remaja Putri.....	10
G. Upaya dan Strategi Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Remaja Perempuan	12
H. Peran Remaja Perempuan sebagai Agen Perubahan	13
I. Kesimpulan	17
J. Referensi.....	18
K. Glosarium.....	21

CHAPTER 2 KESETARAAN GENDER DALAM KEHAMILAN DAN PERSALINAN

.....25

Bd. Muliana, S.Tr.Keb., M.K.M.25

A. Pendahuluan.....	25
B. Konsep Kesetaraan Gender	27
C. Kesetaraan Gender Dalam Kehamilan.....	31
D. Kesetaraan Gender Dalam Persalinan.....	35
E. Dampak Ketidaksetaraan Gender dalam Persalinan terhadap Angka Kematian Ibu dan Bayi.....	38
F. Kebijakan dan Regulasi.....	39
G. Strategi dan Intervensi Kesetaraan Gender	42
H. Studi Kasus dan Best Practices	45
I. Simpulan.....	46
J. Referensi.....	47
K. Glosarium.....	49

CHAPTER 3 KESETARAAN GENDER PADA PEREMPUAN LANSIA	51
Ngatemi, S.Si.T., MKM.....	51
A. Pendahuluan/Prolog	51
B. Konsep Kesetaraan Gender dan Lansia.....	54
C. Dinamika Peran Sosial Perempuan Lansia	58
D. Akses Perempuan Lansia terhadap Layanan Kesehatan	62
E. Kesetaraan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.....	66
F. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Perempuan Lansia.....	70
G. Tantangan Budaya dan Stigma Gender pada Lansia	75
H. Pemberdayaan Perempuan Lansia.....	80
I. Peran Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah.....	84
J. Peluang Inovasi dan Teknologi untuk Kesetaraan Gender Lansia.....	88
K. Simpulan.....	93
L. Referensi.....	95
M. Glosarium.....	97
 PROFIL PENULIS	 103

CHAPTER 1

KESETARAAN GENDER PADA REMAJA PEREMPUAN

Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin 5, yaitu menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (UN DESA, 2024). Pada remaja perempuan, isu ini menjadi sangat penting karena fase remaja merupakan masa transisi menuju dewasa yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan (UNICEF, 2023).

Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam tiga dekade terakhir, remaja perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses pendidikan, rendahnya partisipasi dalam bidang sains dan teknologi, perkawinan anak, serta kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender (UN Women, 2024; UNESCO, 2023). Kesenjangan ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, hingga keterbatasan peluang ekonomi di kemudian hari (WHO, 2024).

Di Indonesia, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender terus dilakukan melalui regulasi dan kebijakan, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memperkuat perlindungan remaja perempuan dari kekerasan (KemenPPPA, 2024). Namun demikian, indikator pembangunan gender nasional masih menunjukkan adanya kesenjangan. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 91,85, yang berarti masih

terdapat ketidaksetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan (BPS, 2024).

Remaja perempuan juga menghadapi persoalan kesehatan menstruasi, di mana keterbatasan akses fasilitas sanitasi di sekolah, rendahnya literasi menstruasi, serta stigma sosial seringkali berdampak pada absensi dan menurunnya prestasi akademik (WHO, 2024). Selain itu, meskipun angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, prevalensinya masih cukup tinggi di beberapa daerah sehingga memerlukan intervensi lintas sektor untuk pencegahannya (UNICEF, 2023; KemenPPPA, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk memberikan edukasi dan penguatan pemahaman mengenai kesetaraan gender kepada remaja perempuan. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, memperkuat partisipasi, serta membekali mereka dengan keterampilan hidup agar mampu melindungi diri, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan mengoptimalkan potensi diri secara setara dengan laki-laki.

B. Konsep Dasar Kesejahteraan Gender

1. Pengertian Gender

Gender merupakan konsep sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, fungsi, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat, bukan semata-mata faktor biologis (Fakih, 2016). Gender berbeda dengan seks (jenis kelamin), karena seks merupakan perbedaan biologis yang melekat sejak lahir, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai waktu, tempat, dan budaya (WHO, 2022).

2. Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, dan perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

2021). Kesenjangan gender juga berarti menghapus diskriminasi, stereotip, serta hambatan struktural yang membatasi peran salah satu jenis kelamin (UN Women, 2020).

3. Prinsip-Prinsip Kesenjangan Gender

Prinsip dasar dalam kesetaraan gender meliputi:

- a. Non-diskriminasi: Semua orang berhak diperlakukan sama tanpa memandang jenis kelamin (CEDAW, 1979).
- b. Keadilan akses dan kesempatan: Perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan (Fakih, 2016).
- c. Penghormatan terhadap hak asasi manusia: Kesenjangan gender merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat universal (UNESCO, 2019).
- d. Pemberdayaan perempuan: Memperkuat posisi perempuan agar dapat setara dalam berbagai bidang (World Bank, 2019).

4. Bentuk Ketidakesetaraan Gender

Menurut Fakih (2016), ketidakesetaraan gender dapat terlihat dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Marginalisasi: Perempuan sering terpinggirkan dari akses ekonomi atau sumber daya.
- b. Subordinasi: Anggapan bahwa peran perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.
- c. Stereotip: Pandangan yang membatasi peran perempuan, misalnya hanya dianggap cocok di ranah domestik.
- d. Kekerasan berbasis gender: Perempuan lebih rentan mengalami kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis.
- e. Beban ganda: Perempuan dituntut mengurus rumah tangga sekaligus bekerja di luar rumah.

5. Pentingnya Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender penting untuk:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena perempuan dan laki-laki sama-sama berkontribusi dalam pembangunan (UNDP, 2020).
- b. Mengurangi kemiskinan dengan memberi kesempatan setara dalam pendidikan dan pekerjaan (World Bank, 2019).
- c. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender (United Nations, 2015).
- d. Mewujudkan keadilan sosial dengan menghapus diskriminasi dan ketidakadilan berbasis gender (Fakih, 2016).

C. Remaja Perempuan Dan Perkembangannya

1. Pengertian Remaja

Remaja adalah fase perkembangan manusia yang berada di antara masa anak-anak dan dewasa, biasanya berlangsung antara usia 10–19 tahun menurut definisi World Health Organization (WHO, 2021). Masa ini ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat, termasuk pencarian identitas diri, kemandirian, dan hubungan dengan lingkungan sekitar (Papalia & Martorell, 2021).

2. Ciri-Ciri Perkembangan Remaja Perempuan

Remaja perempuan memiliki ciri khas perkembangan yang meliputi :

- a. Perubahan biologis berupa pubertas, pertumbuhan payudara, menstruasi, dan perubahan bentuk tubuh (WHO, 2021).
- b. Perubahan psikologis seperti meningkatnya kesadaran diri, pencarian jati diri, serta perubahan suasana hati akibat hormon (Santrock, 2019).
- c. Perubahan sosial berupa interaksi lebih luas dengan teman sebaya, peningkatan kemandirian dari orang tua, serta mulai adanya minat terhadap lawan jenis (Papalia & Martorell, 2021).

3. Perkembangan Biologis Remaja Perempuan

a. Pubertas

Pubertas merupakan proses perubahan fisik menuju kematangan seksual. Pada remaja perempuan, pubertas biasanya terjadi antara usia 8–13 tahun dengan ditandai oleh:

- 1) Pertumbuhan payudara (thelarche).
- 2) Tumbuh rambut kemaluan dan ketiak.
- 3) Menstruasi pertama (menarche) rata-rata usia 12–13 tahun.
- 4) Pertumbuhan tinggi dan berat badan yang cepat (WHO, 2021)

b. Perubahan Hormonal

Hormon estrogen dan progesteron memainkan peran penting dalam perkembangan organ reproduksi, siklus menstruasi, serta perubahan suasana hati (Guyton & Hall, 2021).

c. Kesehatan Reproduksi

Remaja perempuan perlu memahami kesehatan reproduksi, termasuk siklus menstruasi, kebersihan diri saat haid, serta pencegahan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual (BKKBN, 2022).

4. Perkembangan Psikologis Remaja Perempuan

a. Identitas Diri

Remaja berada pada tahap pencarian identitas menurut teori Erikson, yaitu "Identity vs Role Confusion". Remaja perempuan mencoba memahami siapa dirinya, nilai-nilai yang dianut, dan tujuan hidup (Santrock, 2019).

b. Emosi

Remaja perempuan sering mengalami perubahan emosi yang cepat (mood swings) akibat perubahan hormonal dan tekanan sosial. Hal ini dapat menimbulkan rasa cemas, mudah marah, atau perasaan minder (Papalia & Martorell, 2021).

c. Kognitif

Menurut teori Piaget, remaja sudah masuk ke tahap operasional formal, yaitu mampu berpikir abstrak, memecahkan masalah secara logis, dan mempertimbangkan kemungkinan masa depan (Papalia & Martorell, 2021).

5. Perkembangan Sosial Remaja Perempuan

a. Hubungan dengan Keluarga

Remaja perempuan mulai menuntut kemandirian, seringkali terjadi konflik dengan orang tua karena perbedaan pandangan, namun tetap membutuhkan dukungan emosional keluarga (Santrock, 2019).

b. Hubungan dengan Teman Sebaya

Teman sebaya menjadi sangat penting, memengaruhi gaya hidup, perilaku, dan keputusan remaja perempuan. Kelompok sebaya juga menjadi tempat untuk belajar bersosialisasi dan membentuk identitas (Papalia & Martorell, 2021).

c. Hubungan dengan Lawan Jenis

Ketertarikan terhadap lawan jenis mulai berkembang pada masa remaja. Penting bagi remaja perempuan mendapat pendidikan seksualitas yang benar untuk mencegah pernikahan dini, kehamilan remaja, serta penyakit menular seksual (BKKBN, 2022).

6. Masalah yang Sering Dihadapi Remaja Perempuan

a. Masalah kesehatan reproduksi: anemia, keputihan, nyeri haid, serta kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi (WHO, 2021).

b. Masalah psikologis: depresi, kecemasan, rendah diri akibat tekanan sosial dan media (Santrock, 2019).

c. Masalah sosial: pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, kekerasan berbasis gender, serta perundungan (Kemen PPPA, 2021).

d. Gizi dan pola makan: remaja perempuan berisiko kekurangan zat besi dan kalsium, terutama bila pola makan tidak seimbang (UNICEF, 2020).

7. Pentingnya Pendidikan dan Dukungan

Remaja perempuan memerlukan :

- a. Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan dan mencegah risiko kesehatan (BKKBN, 2022).
- b. Dukungan keluarga berupa komunikasi terbuka, kasih sayang, dan bimbingan.
- c. Lingkungan sekolah dan masyarakat yang ramah remaja, memberikan kesempatan setara dalam pendidikan dan aktivitas (Kemen PPPA, 2021).
- d. Pemberdayaan diri melalui keterampilan hidup (life skills) seperti pengendalian diri, pengambilan keputusan, dan kemampuan komunikasi (WHO, 2021).

D. Isu-Isu Gender pada Remaja Perempuan

1. Stereotip dan Diskriminasi Gender

Remaja perempuan sering menghadapi stereotip yang menganggap bahwa mereka lebih cocok berada di ranah domestik, harus bersikap lemah lembut, dan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi. Stereotip ini melahirkan diskriminasi dalam bentuk keterbatasan kesempatan di bidang pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi sosial (Fakih, 2016). Akibatnya, remaja perempuan kurang percaya diri dan terhambat dalam mengembangkan potensi dirinya (UN Women, 2020).

2. Kesenjangan Pendidikan dan Akses

Di beberapa daerah, anak perempuan lebih berisiko putus sekolah karena alasan ekonomi, budaya, atau pernikahan dini. Data BPS dan UNICEF (2020) menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah pada remaja perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama di pedesaan. Kesenjangan pendidikan ini berdampak jangka panjang terhadap kesempatan kerja, partisipasi dalam pembangunan, serta siklus kemiskinan antar generasi.

3. Pernikahan Usia Anak dan Kehamilan Remaja

Pernikahan usia anak masih menjadi isu gender serius. Sekitar 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun (BPS & UNICEF, 2020). Pernikahan dini sering berujung pada kehamilan remaja, yang meningkatkan risiko komplikasi obstetri, anemia, dan bahkan kematian ibu dan bayi (WHO,

2021). Selain itu, kehamilan remaja juga mengakibatkan putus sekolah dan hilangnya kesempatan untuk berkembang secara optimal.

4. Kekerasan Berbasis Gender

Remaja perempuan lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender, baik di sekolah, rumah, maupun ruang publik. Bentuknya meliputi bullying, pelecehan seksual, hingga kekerasan dalam pacaran (dating violence). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR, 2021) menemukan bahwa 1 dari 17 remaja perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Dampaknya mencakup trauma psikologis, rendahnya rasa aman, serta risiko kesehatan reproduksi.

5. Keterbatasan Akses Kesehatan Reproduksi dan Informasi Seksual

Banyak remaja perempuan masih kesulitan memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang benar, akurat, dan ramah remaja. Akibatnya, mereka rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan perilaku seksual berisiko (BKKB, 2022). Hambatan sering muncul karena tabu budaya, kurangnya pendidikan seks komprehensif, serta keterbatasan layanan ramah remaja.

6. Beban Ganda

Selain bersekolah, remaja perempuan sering dibebani pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, atau mengurus adik. Beban ganda ini membuat mereka kelelahan, kurang waktu belajar, dan sulit berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau organisasi sekolah (Kemen PPPA, 2021). Kondisi ini memperkuat ketidaksetaraan gender karena remaja perempuan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.

E. Hak-Hak Remaja Perempuan

1. Hak Pendidikan

Remaja perempuan berhak memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin dalam

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 4 mengenai pendidikan berkualitas. Namun, kenyataannya masih banyak remaja perempuan yang terhambat melanjutkan sekolah akibat pernikahan dini, kemiskinan, atau budaya patriarki (BPS & UNICEF, 2020). Pemenuhan hak pendidikan sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Hak Kesehatan, termasuk Kesehatan Reproduksi

Setiap remaja perempuan berhak memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk kesehatan reproduksi, tanpa stigma dan diskriminasi. WHO (2021) menegaskan bahwa akses terhadap informasi tentang pubertas, menstruasi, kontrasepsi, serta pencegahan infeksi menular seksual adalah bagian dari hak kesehatan reproduksi. Di Indonesia, pemenuhan hak ini didukung oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) dari Kementerian Kesehatan.

3. Hak Perlindungan dari Kekerasan

Remaja perempuan berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional, maupun psikologis. Perlindungan ini dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) serta Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, survei menunjukkan bahwa remaja perempuan masih rentan terhadap bullying, pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran, hingga pernikahan paksa (SNPHAR, 2021).

4. Hak Partisipasi Sosial dan Politik

Remaja perempuan berhak berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik sesuai tingkat usianya. Partisipasi ini meliputi hak untuk bersuara, berorganisasi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka (UNICEF, 2021). Di Indonesia, hak partisipasi diakui dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendorong peran aktif remaja, termasuk perempuan, dalam pembangunan bangsa.

5. Hak atas Kebebasan Berekspresi

Remaja perempuan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, dan mengakses informasi, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Hak ini dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, dalam praktiknya, remaja perempuan sering dibatasi oleh norma sosial atau mengalami diskriminasi dalam mengekspresikan diri, baik di sekolah, keluarga, maupun media sosial (UN Women, 2020).

F. Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Gender pada Remaja Putri

1. Faktor Budaya dan Norma Sosial

Budaya dan norma sosial memiliki pengaruh besar terhadap peran gender. Di banyak masyarakat, perempuan masih ditempatkan pada ranah domestik, sementara laki-laki dianggap lebih pantas di ranah publik. Norma ini memengaruhi pandangan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta kebebasan berekspresi remaja putri (Fakih, 2016). Stereotip seperti “perempuan harus lembut dan patuh” dapat membatasi ruang gerak remaja putri dan memperkuat ketidaksetaraan.

2. Faktor Agama dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan sering kali dijadikan dasar dalam menentukan peran sosial laki-laki dan perempuan. Jika dipahami secara sempit, ajaran agama dapat memperkuat subordinasi perempuan. Namun, bila ditafsirkan secara adil dan progresif, agama justru dapat menjadi landasan kesetaraan gender dengan menekankan nilai keadilan, penghormatan, dan martabat manusia (UN Women, 2020).

3. Faktor Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk pandangan gender anak. Orang tua yang memberikan kesempatan belajar dan kebebasan setara bagi anak laki-laki dan perempuan mendorong tumbuhnya kesadaran kesetaraan

gender. Sebaliknya, keluarga yang membebankan pekerjaan domestik hanya pada anak perempuan dapat memperkuat ketidakadilan gender sejak dini (Kemen PPPA, 2021).

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan formal berperan penting dalam membentuk pemahaman kesetaraan gender. Sekolah yang menerapkan kurikulum responsif gender dapat mengurangi stereotip, memberi ruang partisipasi yang sama, serta meningkatkan prestasi remaja putri (UNESCO, 2019). Namun, kesenjangan akses pendidikan masih terjadi, terutama di pedesaan, sehingga memengaruhi kualitas hidup remaja putri (BPS & UNICEF, 2020).

5. Faktor Media dan Teknologi

Media massa dan media sosial dapat memperkuat maupun melemahkan kesetaraan gender. Di satu sisi, media sering menampilkan citra perempuan secara stereotip, misalnya menekankan kecantikan fisik dibanding prestasi. Di sisi lain, teknologi digital memberi ruang bagi remaja putri untuk berekspresi, mengakses informasi kesehatan reproduksi, serta memperjuangkan hak-hak mereka (UNICEF, 2021).

6. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan negara berperan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan program Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi dasar perlindungan dan pemberdayaan remaja putri. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum (Kemen PPPA, 2021).

G. Upaya dan Strategi Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Remaja Perempuan

1. Pendidikan Kesetaraan Gender di Sekolah dan Keluarga

Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun kesadaran kesetaraan gender.

- a. Di sekolah, penerapan kurikulum yang responsif gender dapat mengurangi stereotip dan diskriminasi. Guru perlu memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik (UNESCO, 2019).
- b. Di keluarga, orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai kesetaraan sejak dini, misalnya dengan membagi tugas rumah tangga secara adil, memberikan kebebasan berekspresi, dan mendukung pendidikan anak perempuan sama seperti anak laki-laki (Kemen PPPA, 2021).

2. Pemberdayaan Remaja Perempuan melalui Organisasi dan Ekstrakurikuler

Remaja perempuan perlu dilibatkan dalam kegiatan organisasi sekolah, ekstrakurikuler, maupun komunitas.

- a. Partisipasi ini mengasah kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan kepercayaan diri (UN Women, 2020).
- b. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui organisasi remaja, kelompok studi, pramuka, palang merah remaja, atau komunitas berbasis hobi.
- c. Hal ini juga memberi ruang aman bagi remaja perempuan untuk berpendapat, mengambil keputusan, dan memperjuangkan haknya.

3. Peran Media Massa dan Media Sosial

Media berperan ganda dalam isu kesetaraan gender.

- a. Media massa seharusnya menampilkan perempuan secara adil, tidak hanya dari sisi penampilan fisik, tetapi juga prestasi dan kontribusinya.
- b. Media sosial dapat menjadi ruang positif bagi remaja perempuan untuk berekspresi, berbagi informasi kesehatan reproduksi, kampanye anti kekerasan, dan advokasi gender (UNICEF, 2021).

- c. Literasi digital perlu ditingkatkan agar remaja perempuan mampu memfilter informasi negatif, menghindari cyberbullying, dan memanfaatkan media secara produktif.

4. Program dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi dan program yang berpihak pada remaja perempuan, seperti :

- a. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan (Kemen PPPA, 2021).
- b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan remaja, termasuk perempuan, mendapat layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan berkualitas.
- c. Peraturan Pencegahan Perkawinan Anak, yang diperkuat dengan revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun.

5. Peran Lembaga Non-Pemerintah dan Komunitas

Lembaga non-pemerintah (NGO) dan komunitas masyarakat berperan dalam advokasi, edukasi, dan pendampingan remaja perempuan.

- a. NGO seperti Plan International, Save the Children, dan Yayasan Kesehatan Perempuan aktif memberikan edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, dan pemberdayaan ekonomi remaja putri.
- b. Komunitas lokal dapat membentuk forum remaja, pusat informasi remaja, atau kegiatan sosial yang memberi ruang aman bagi anak perempuan untuk berkembang (UNFPA, 2020).

H. Peran Remaja Perempuan sebagai Agen Perubahan

Remaja perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Dengan jumlah populasi remaja yang signifikan, kontribusi mereka dapat memengaruhi arah pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa (UNFPA, 2020). Agen perubahan (change agent) berarti individu atau

kelompok yang mampu mendorong, memimpin, dan menginspirasi terjadinya perubahan positif di lingkungannya.

1. Kesadaran Diri dan *Self-Empowerment*

Kesadaran diri merupakan langkah awal bagi remaja perempuan untuk menjadi agen perubahan.

- a. *Self-empowerment* adalah proses memperkuat diri melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat (Kemen PPPA, 2021).
- b. Remaja perempuan yang memiliki kesadaran diri akan lebih mampu menolak diskriminasi, melawan stereotip gender, dan memperjuangkan haknya, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat (UNICEF, 2021).
- c. Contoh konkret adalah ketika remaja perempuan berani berbicara tentang hak pendidikan, kesehatan reproduksi, atau menolak praktik pernikahan dini di lingkungannya.

2. Kepemimpinan Remaja Perempuan

Kepemimpinan tidak selalu berarti memimpin organisasi besar, tetapi juga memimpin diri sendiri dan memberi teladan di lingkungan kecil.

- a. Remaja perempuan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam OSIS, pramuka, organisasi remaja masjid, karang taruna, dan forum anak (UNESCO, 2019).
- b. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh remaja perempuan dapat menginspirasi teman sebaya untuk lebih aktif, percaya diri, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
- c. Penguatan kepemimpinan perempuan sejak remaja juga menjadi strategi penting dalam mencetak calon pemimpin perempuan di masa depan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (UN Women, 2020).

3. Keterlibatan dalam Gerakan Sosial

Remaja perempuan dapat menjadi motor penggerak dalam isu-isu sosial yang berkaitan dengan kesetaraan gender, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.

- a. Mereka dapat terlibat dalam kampanye kesetaraan gender, gerakan literasi, advokasi kesehatan reproduksi, atau kegiatan lingkungan hidup.
- b. Media sosial memberi peluang besar bagi remaja perempuan untuk menyuarkan gagasan, misalnya melalui kampanye digital, konten edukatif, dan aktivisme online (UNICEF, 2021).
- c. Keterlibatan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri, solidaritas, dan kepemimpinan remaja perempuan itu sendiri.

4. Contoh Tokoh Inspiratif Perempuan

Tokoh-tokoh perempuan yang berhasil menjadi agen perubahan dapat menjadi teladan bagi remaja perempuan.

a. Lokal:

- 1) *Najwa Shihab* – jurnalis dan pendiri *Narasi*, aktif mengadvokasi literasi dan kebebasan berekspresi di kalangan anak muda.
- 2) *Kartini Nurdin* – tokoh perempuan Sulawesi Selatan yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan.

b. Nasional:

- 1) *Raden Ajeng Kartini* – pelopor emansipasi perempuan Indonesia melalui perjuangan hak pendidikan.
- 2) *Tri Rismaharini* – Wali Kota Surabaya (2005–2020) yang berhasil meningkatkan layanan publik, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

c. Internasional:

- 1) *Malala Yousafzai* – aktivis pendidikan asal Pakistan, peraih Nobel Perdamaian termuda, yang memperjuangkan hak anak perempuan untuk bersekolah.

- 2) *Greta Thunberg* – aktivis lingkungan asal Swedia yang memimpin gerakan global melawan perubahan iklim, menginspirasi jutaan remaja di seluruh dunia.

Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa remaja perempuan dapat menjadi agen perubahan melalui pendidikan, kepemimpinan, advokasi, maupun keberanian menyuarakan kebenaran.

5. Dampak Positif Kesetaraan Gender bagi Remaja Perempuan

Kesetaraan gender memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan remaja perempuan. Dengan adanya kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial, remaja perempuan dapat mengoptimalkan potensinya sehingga mampu berkontribusi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat (UNESCO, 2019). Berikut beberapa dampak positif yang dapat dirasakan:

a. Peningkatan Akses Pendidikan

- 1) Kesetaraan gender membuka peluang yang sama bagi remaja perempuan untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan tinggi, dan memperoleh keterampilan sesuai minat dan bakat mereka.
- 2) Akses pendidikan yang adil berdampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta mobilitas sosial remaja perempuan (Kemen PPPA, 2021).
- 3) Remaja perempuan yang berpendidikan cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis, lebih mandiri dalam mengambil keputusan, serta lebih mampu menolak praktik diskriminatif seperti pernikahan dini (UNICEF, 2021).

b. Kesempatan Kerja dan Karier yang Lebih Luas

- 1) Dengan pendidikan yang setara, remaja perempuan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja formal maupun non-formal di masa depan.

- 2) Kesenjangan gender mendorong perempuan untuk dapat bersaing dalam berbagai bidang, termasuk bidang yang selama ini didominasi laki-laki, seperti sains, teknologi, politik, dan kewirausahaan (UN Women, 2020).
 - 3) Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kemandirian ekonomi perempuan dan pengurangan kesenjangan gender di pasar kerja (World Bank, 2020).
- c. Kesehatan Mental dan Fisik yang Lebih Baik
- 1) Kesenjangan gender memungkinkan remaja perempuan memperoleh akses layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan mental, tanpa diskriminasi.
 - 2) Remaja perempuan yang diberdayakan lebih percaya diri, memiliki harga diri tinggi, serta lebih sedikit mengalami kecemasan atau depresi akibat tekanan sosial dan diskriminasi (WHO, 2021).
 - 3) Akses kesehatan yang setara juga menurunkan risiko kehamilan usia remaja, infeksi menular seksual, serta kekerasan berbasis gender.
- d. Terciptanya Generasi Tangguh, Mandiri, dan Setara
- 1) Kesenjangan gender berkontribusi pada lahirnya generasi remaja perempuan yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup, baik di bidang pendidikan, karier, maupun kehidupan sosial (UNFPA, 2020).
 - 2) Remaja perempuan yang tumbuh dalam lingkungan setara lebih mandiri, berdaya saing, serta siap menjadi pemimpin masa depan.
 - 3) Generasi tangguh dan setara ini juga mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif.

I. Kesimpulan

Kesenjangan gender pada remaja perempuan merupakan isu penting karena menyangkut hak asasi, kualitas hidup, dan masa depan bangsa. Remaja perempuan berada pada fase perkembangan yang menentukan identitas diri, pola pikir, serta peran sosial. Kesenjangan gender tidak hanya berarti persamaan biologis, tetapi juga

akses, kesempatan, partisipasi, dan kontrol yang setara dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial politik.

Namun, remaja perempuan masih menghadapi diskriminasi, stereotip gender, pernikahan usia anak, kekerasan berbasis gender, keterbatasan akses kesehatan reproduksi, hingga beban ganda. Hambatan budaya, sosial, ekonomi, serta kuatnya norma patriarki membuat kesetaraan gender sulit terwujud.

Padahal, kesetaraan gender berdampak positif bagi individu maupun masyarakat. Remaja perempuan yang memperoleh pendidikan dan kesehatan setara akan lebih berkualitas, terhindar dari risiko pernikahan dini dan masalah reproduksi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan dan menjadi agen perubahan.

Untuk mencapainya, dibutuhkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, media, pemerintah, dan lembaga internasional. Pendidikan kesetaraan gender sejak dini, pemberdayaan remaja melalui organisasi atau komunitas, serta dukungan kebijakan perlindungan menjadi kunci penting.

Dengan demikian, kesetaraan gender pada remaja perempuan adalah kebutuhan mendasar guna menciptakan generasi emas yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan.

J. Referensi

-
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Modul Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik (BPS) & UNICEF. (2020). Kemajuan yang Tertunda: Analisis Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia Tahun 2024. Jakarta: BPS.
- CEDAW. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. New York: United Nations.

- Fakih, M. (2016). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). Textbook of Medical Physiology (14th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021). Laporan Ketidaksetaraan Gender pada Remaja di Indonesia. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021). Laporan Kesetaraan Gender di Indonesia. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021). Profil Gender Remaja Indonesia. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2024). Profil Perempuan Indonesia 2024. Jakarta: Kemen PPPA.
- Papalia, D. E., & Martorell, G. (2021). Experience Human Development (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Santrock, J. W. (2019). Adolescence (17th ed.). New York: McGraw-Hill.
- SNPHAR. (2021). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Jakarta: Kemen PPPA & UNICEF.
- UN DESA. (2024). Sustainable Development Goals Report 2024: Goal 5 Gender Equality. New York: United Nations.
- UN Women. (2020). Gender Equality: Women's Rights in Review 25 Years after Beijing. New York: UN Women.
- UN Women. (2020). Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World. New York: UN Women.

- UN Women. (2020). Women's Leadership and Political Participation. New York: UN Women.
- UN Women. (2024). Gender Equality: Global Progress and Challenges. New York: UN Women.
- UNDP. (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene. New York: UNDP.
- UNESCO. (2019). Gender Equality: Heritage and Creativity. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2019). Global Education Monitoring Report: Gender Report. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2023). Cracking the Code: Girls' and Women's Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Paris: UNESCO.
- UNFPA. (2020). Adolescent Girls' Agency and Empowerment. New York: UNFPA.
- UNFPA. (2020). Adolescent Girls' Sexual and Reproductive Health. New York: UNFPA.
- UNICEF. (2020). Adolescent Nutrition: A Review of the Situation in Selected Countries. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2021). Adolescents as Agents of Change: Promoting Rights and Empowerment. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2021). The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2023). Is an End to Child Marriage Within Reach? Latest Trends and Future Prospects. New York: UNICEF.
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.
- WHO. (2021). Adolescent Health and Development. Geneva: World Health Organization.

WHO. (2021). Adolescent Health and Well-being: A Global Report. Geneva: World Health Organization.

WHO. (2022). Gender and Health. Geneva: World Health Organization.

WHO. (2024). Global Report on Menstrual Health and Hygiene in Schools. Geneva: World Health Organization.

World Bank. (2019). Gender Equality and Development. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2020). Women, Business and the Law 2020. Washington, DC: World Bank

K. Glosarium

Adolescence (Masa Remaja)	:	Fase perkembangan manusia antara masa anak-anak dan dewasa, biasanya usia 10–19 tahun, ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial
Agen Perubahan (Change Agent)	:	Individu atau kelompok yang mampu mendorong, memimpin, dan menginspirasi terjadinya perubahan positif di lingkungannya.
Beban Ganda	:	Kondisi ketika perempuan, termasuk remaja, dituntut menjalankan pekerjaan domestik sekaligus berpartisipasi dalam pendidikan atau pekerjaan publik.
Diskriminasi Gender	:	Perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin yang membatasi hak, kesempatan, dan peran sosial.
Emansipasi Perempuan	:	Upaya untuk memberikan kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak yang sama bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
Gender	:	Konsep sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, fungsi, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan, berbeda dengan seks (jenis kelamin) yang bersifat biologis.
Hak Asasi Manusia (HAM)	:	Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari kekerasan.

Hak Reproduksi	:	Hak individu, termasuk remaja, untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, aman, serta bebas dari diskriminasi.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	:	Indikator yang mengukur kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Kesetaraan Gender	:	Kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, dan perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan.
Kesehatan Reproduksi Remaja	:	Kondisi sehat fisik, mental, dan sosial terkait sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya pada usia remaja.
Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	:	Segala bentuk kekerasan yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, baik fisik, seksual, maupun psikologis.
Marginalisasi	:	Proses peminggiran kelompok tertentu, misalnya perempuan, dari akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, maupun sosial.
Non-diskriminasi	:	Prinsip perlakuan setara tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, agama, atau latar belakang lainnya.
Partisipasi Sosial dan Politik	:	Keterlibatan aktif individu dalam kegiatan sosial, budaya, atau politik, termasuk hak untuk bersuara dan mengambil keputusan.
Patriarki	:	Sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dibanding perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
Pemberdayaan Perempuan	:	Proses meningkatkan posisi, kapasitas, dan kemandirian perempuan agar setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang.
Pernikahan Usia Anak	:	Perkawinan yang dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 tahun, yang berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan remaja.
Pubertas	:	Proses perubahan fisik menuju kematangan seksual pada remaja, ditandai dengan menarche pada perempuan dan perubahan tubuh lainnya.
Remaja Perempuan	:	Anak perempuan yang berada pada rentang usia 10–19 tahun yang sedang mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan sosial.

Self-Empowerment (Pemberdayaan Diri)	:	Proses memperkuat diri melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri sehingga mampu mengambil keputusan secara tepat.
Seks	:	Perbedaan biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan sejak lahir, seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon.
Stereotip Gender	:	Pandangan atau keyakinan yang membatasi peran perempuan dan laki-laki, misalnya perempuan dianggap hanya pantas di ranah domestik.
Subordinasi	:	Anggapan bahwa peran atau kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.
Sustainable Development Goals (SDGs)	:	Agenda pembangunan global yang salah satu tujuannya (Tujuan ke-5) adalah mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.

CHAPTER 2

KESETERAAN GENDER DALAM KEHAMILAN DAN PERSALINAN

Bd. Muliana, S.Tr.Keb., M.K.M.

A. Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global yang semakin menonjol dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam konteks kehamilan dan persalinan, kesenjangan gender tidak hanya berimplikasi pada kesejahteraan ibu, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup anak dan keluarga secara keseluruhan. Ketika perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, layanan kesehatan, maupun dukungan sosial, maka risiko komplikasi kehamilan dan persalinan akan meningkat signifikan. Hal ini diperparah oleh anggapan tradisional yang menempatkan kehamilan hanya sebagai tanggung jawab perempuan semata, sehingga mengabaikan keterlibatan laki-laki sebagai pasangan yang seharusnya berperan aktif. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesetaraan gender dalam kehamilan menjadi krusial, karena menyangkut hak dasar perempuan untuk hidup sehat, aman, dan bermartabat. Kesetaraan gender juga bukan hanya isu perempuan, melainkan kepentingan bersama demi terwujudnya keluarga yang lebih sejahtera. Dengan kata lain, keberhasilan dalam kehamilan dan persalinan akan lebih optimal jika dibangun melalui dukungan bersama antara perempuan, laki-laki, keluarga, dan masyarakat.

Menurut World Health Organization (2021), kesenjangan gender dalam akses layanan kesehatan ibu masih menjadi tantangan besar di banyak negara berkembang, termasuk di Asia dan Afrika. Data menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan laki-laki dalam keputusan kesehatan keluarga berdampak pada keterlambatan ibu hamil dalam mengakses pelayanan antenatal dan

kegawatdaruratan obstetri. Selain itu, faktor seperti norma budaya, distribusi kekuasaan dalam rumah tangga, serta peran gender tradisional turut membatasi ruang gerak perempuan dalam menentukan pilihan terbaik bagi dirinya sendiri. Perempuan sering kali membutuhkan izin suami atau keluarga untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga memperpanjang waktu penanganan ketika terjadi komplikasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, karena berakar pada sistem sosial dan budaya yang telah mengakar lama.

Bhatt et al. (2022) menegaskan bahwa intervensi yang berorientasi pada kesehatan ibu akan lebih efektif apabila juga melibatkan laki-laki, komunitas, dan pembuat kebijakan dalam mengubah norma gender yang diskriminatif. Oleh sebab itu, upaya perbaikan layanan kesehatan ibu harus sejalan dengan strategi pemberdayaan gender secara menyeluruh.

Di sisi lain, perkembangan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan kesetaraan gender dan kesehatan ibu sebagai prioritas dalam agenda pembangunan internasional. Tujuan kelima (kesetaraan gender) menekankan pentingnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi. Sementara itu, tujuan ketiga (kesehatan) menargetkan penurunan angka kematian ibu dan peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh perempuan. Indonesia sendiri telah mengadopsi berbagai kebijakan nasional, seperti program Jaminan Persalinan (Jampersal), penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan berbasis gender. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan, terutama dalam memastikan partisipasi laki-laki secara nyata dalam kehamilan dan persalinan.

Penelitian Putri dan Setyowati (2021) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah berpihak pada kesetaraan gender, praktik di lapangan masih sering memperlihatkan dominasi peran perempuan dalam mengurus kesehatan

reproduksinya sendiri. Dengan demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh agar kesenjangan antara kebijakan dan realitas dapat diatasi.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk membahas kesetaraan gender dalam kehamilan dan persalinan secara mendalam melalui berbagai perspektif. Pembahasan tidak hanya mencakup dimensi konseptual yang menjelaskan makna dan ruang lingkup kesetaraan gender, tetapi juga aspek kebijakan yang berperan sebagai landasan hukum dan regulasi. Selain itu, strategi intervensi yang melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat luas perlu diuraikan untuk memberikan gambaran praktik yang dapat diterapkan. Lebih jauh lagi, studi kasus dan praktik terbaik dari berbagai negara dapat menjadi referensi untuk memperkuat upaya Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam kehamilan dan persalinan merupakan isu kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Jika hal ini diabaikan, maka akan sulit mencapai target SDGs, terutama terkait kesehatan ibu dan kesetaraan gender. Oleh sebab itu, pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan praktis untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

B. Konsep Kesetaraan Gender

1. Definisi Gender dan Kesetaraan Gender

Gender merujuk pada konstruksi sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Definisi ini berbeda dari seks yang bersifat biologis, karena gender dapat berubah sesuai konteks sosial, budaya, dan waktu (Connell, 2019). Dalam perspektif pembangunan, gender dipandang sebagai aspek penting yang menentukan bagaimana individu dapat mengakses sumber daya, peluang, dan layanan publik. Kesetaraan gender berarti adanya keadilan dalam distribusi hak, kewajiban, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi.

Dalam konteks kesehatan, kesetaraan gender menegaskan bahwa perempuan berhak atas layanan kesehatan reproduksi yang aman, terjangkau, dan berkualitas. Hal ini juga menuntut keterlibatan laki-laki dalam mendukung kesehatan pasangan mereka. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya persoalan normatif, melainkan juga strategi pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (UN Women, 2020).

Kesetaraan gender dalam bidang kesehatan ibu menekankan pentingnya akses yang sama terhadap informasi, layanan medis, dan dukungan sosial. Perempuan harus memiliki kebebasan penuh untuk mengambil keputusan terkait kehamilan, persalinan, dan penggunaan layanan kesehatan tanpa adanya paksaan. Menurut Kabeer (2021), kesetaraan gender bukan hanya menyangkut pemberian hak yang sama secara formal, tetapi juga transformasi struktural yang memungkinkan perempuan menikmati hasil pembangunan secara adil. Dalam praktiknya, kesetaraan gender di bidang kesehatan sering kali menghadapi tantangan berupa diskriminasi, bias budaya, dan keterbatasan akses ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan perempuan, terutama di negara berkembang, masih menghadapi risiko tinggi dalam proses kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, kesetaraan gender harus dipahami sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif, pembangunan kesehatan akan mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif.

2. Perbedaan Seks dan Gender

Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon. Perbedaan ini bersifat alamiah dan relatif tidak berubah sepanjang hidup individu (WHO, 2021). Sebaliknya, gender adalah konstruksi sosial yang menjelaskan peran, perilaku, dan ekspektasi yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Misalnya, perempuan sering diidentikkan dengan peran pengasuhan, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Perbedaan ini bukan hasil dari faktor biologis,

melainkan hasil internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Dengan demikian, seks bersifat universal, sementara gender dapat berbeda antar masyarakat dan berubah seiring perkembangan zaman. Pemahaman perbedaan ini penting agar kebijakan kesehatan tidak bias terhadap salah satu jenis kelamin.

Perbedaan antara seks dan gender memiliki implikasi besar terhadap kesehatan reproduksi. Jika seks menekankan pada kebutuhan biologis seperti kehamilan atau persalinan, maka gender menyoroti bagaimana peran sosial dapat memengaruhi pengalaman kesehatan seseorang. Perempuan mungkin menghadapi hambatan budaya dalam mengakses layanan medis meskipun kebutuhan biologis mereka sangat mendesak. Sebaliknya, laki-laki mungkin dihambat oleh norma maskulinitas yang membuat mereka enggan terlibat dalam mendukung kehamilan pasangan.

Menurut Sarker et al. (2020), ketidakjelasan pemahaman antara seks dan gender sering menyebabkan kesalahan dalam perumusan kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, pemisahan konsep ini sangat penting agar intervensi kesehatan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang seks dan gender dapat meningkatkan efektivitas strategi kesehatan reproduksi.

3. Perspektif Teori Gender (Feminisme, Konstruksi Sosial, Hak Asasi Manusia)

Perspektif teori gender memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami ketidaksetaraan dalam kehamilan dan persalinan. Teori feminis menekankan perlunya menghapuskan dominasi patriarki yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan reproduksi. Sementara itu, teori konstruksi sosial melihat gender sebagai produk budaya dan norma masyarakat yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembagian peran selama kehamilan dan persalinan. Dengan demikian, perubahan dalam kesehatan reproduksi tidak hanya menuntut intervensi medis, tetapi juga transformasi budaya dan norma sosial. Perspektif hak asasi manusia menegaskan bahwa

kesehatan merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara bagi semua orang tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender (Kabeer, 2021).

Dalam konteks ini, kesetaraan gender dipandang sebagai prasyarat penting untuk mencapai keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak reproduktif perempuan. Ketiga perspektif tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi harus dilihat secara multidimensi, tidak hanya dari sisi medis tetapi juga sosial, politik, dan hukum. Dengan demikian, pendekatan teoritis ini membantu memperluas pemahaman tentang tantangan sekaligus solusi dalam mewujudkan kesetaraan gender.

4. Kesetaraan Gender dalam Kesehatan Reproduksi

Kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi berarti perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, layanan kesehatan, serta dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan reproduksi. Hal ini meliputi akses terhadap pelayanan antenatal, persalinan yang aman, penggunaan kontrasepsi, serta perawatan pasca persalinan yang berkualitas. Di banyak negara, kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi sering kali terganggu oleh bias medis dan diskriminasi, misalnya ketika keputusan medis lebih banyak didominasi oleh pihak keluarga atau tenaga kesehatan tanpa melibatkan perempuan sebagai subjek utama (Morrison et al., 2022).

Pendekatan *gender-responsive healthcare* kemudian muncul sebagai solusi, yaitu bentuk pelayanan kesehatan yang peka terhadap perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan risiko antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek biologis, tetapi juga dimensi sosial dan psikologis yang memengaruhi pengalaman reproduksi perempuan. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pelayanan kesehatan responsif gender mampu menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan kepuasan pasien, dan memperkuat partisipasi laki-laki dalam mendukung kesehatan reproduksi (Bhatt et al., 2022). Oleh karena itu, penerapan perspektif kesetaraan gender dalam

kesehatan reproduksi menjadi strategi penting untuk membangun sistem kesehatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

C. Kesetaraan Gender Dalam Kehamilan

1. Peran Perempuan dalam Kehamilan

Perempuan merupakan faktor utama dalam kehamilan karena secara biologis merekalah yang mengalami perubahan fisik, hormonal, dan psikologis selama sembilan bulan masa gestasi. Peran perempuan dalam kehamilan tidak hanya terbatas pada fungsi biologis, tetapi juga mencakup pengelolaan kesehatan diri, kepatuhan terhadap pemeriksaan antenatal care (ANC), serta pemeliharaan gizi yang baik. Menurut WHO (2021), pemenuhan peran perempuan dalam kehamilan sering kali terkendala oleh keterbatasan akses informasi dan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah pedesaan. Keterbatasan tersebut memperbesar risiko komplikasi seperti anemia, hipertensi dalam kehamilan, atau preeklamsia yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan, akses ekonomi, dan kemandirian mengambil keputusan sangat penting. Dengan kemandirian tersebut, perempuan dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan kehamilan. Sehingga, pemahaman mengenai peran perempuan dalam kehamilan menjadi bagian penting dalam menciptakan kesetaraan gender.

Selain itu, perempuan berperan dalam menjaga kesehatan psikologis selama kehamilan, yang sering kali diabaikan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Tekanan sosial, stigma, serta beban ganda yang dialami perempuan dapat memperburuk kondisi emosional mereka. Penelitian Kawakami et al. (2023) menekankan bahwa depresi antenatal lebih sering dialami oleh perempuan yang tidak mendapat dukungan emosional dari pasangan maupun keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kehamilan bukan hanya sebagai penerima layanan kesehatan, melainkan juga sebagai individu yang harus diperhatikan kesejahteraan psikososialnya. Jika kesehatan mental ibu hamil

terganggu, maka dapat memengaruhi kualitas hubungan dengan janin dan meningkatkan risiko persalinan prematur. Oleh karena itu, penting bagi sistem kesehatan untuk memberikan layanan holistik yang memperhatikan dimensi fisik dan mental perempuan hamil. Dengan cara ini, peran perempuan dalam kehamilan dapat dijalankan secara lebih optimal dan setara.

2. Peran Laki-laki/Suami dalam Kehamilan

Peran laki-laki atau suami dalam kehamilan sering kali dipandang sebagai faktor sekunder, padahal keberadaannya sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan bayi. Suami memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional, finansial, serta dalam proses pengambilan keputusan medis.

Menurut Mutua et al. (2020), keterlibatan suami dalam kunjungan ANC terbukti meningkatkan kepatuhan perempuan terhadap jadwal pemeriksaan, konsumsi suplemen gizi, serta mempercepat penanganan komplikasi. Selain itu, dukungan finansial dari suami juga memastikan akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Namun, norma patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat membuat laki-laki sering dianggap tidak pantas hadir dalam ruang pelayanan kebidanan. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam kehamilan menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender harus mencakup penghapusan hambatan kultural yang membatasi partisipasi laki-laki.

Dukungan emosional dari suami juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental ibu hamil. Penelitian Kawakami et al. (2023) menunjukkan bahwa ibu hamil yang merasa mendapat perhatian, empati, dan keterlibatan dari pasangannya cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah. Sebaliknya, kurangnya dukungan dari suami dapat memperbesar risiko depresi antenatal, kecemasan, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, peran suami dalam pengambilan keputusan medis sangat krusial, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan obstetri. Keterlibatan mereka dapat mempercepat rujukan ke fasilitas kesehatan, sehingga menurunkan risiko kematian ibu. Oleh karena itu, keterlibatan laki-laki dalam kehamilan bukan sekadar dukungan moral, tetapi

juga strategi kesehatan masyarakat yang efektif. Dengan meningkatkan partisipasi laki-laki, maka kesetaraan gender dalam kehamilan dapat tercapai lebih nyata.

3. Tantangan Kesetaraan Gender dalam Masa Kehamilan

Kesetaraan gender dalam masa kehamilan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari budaya patriarki hingga keterbatasan akses layanan kesehatan. Budaya patriarki masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang kurang memiliki otoritas dalam menentukan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Menurut Mutua et al. (2020), norma budaya di banyak negara berkembang masih memandang kehamilan sebagai urusan domestik perempuan semata, sehingga membatasi partisipasi laki-laki. Hal ini mengakibatkan perempuan sering harus menanggung beban ganda dalam menjaga kesehatan kehamilan tanpa dukungan memadai. Di sisi lain, akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan masih rendah akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Hambatan ini semakin memperlebar kesenjangan gender karena perempuan dari kelompok miskin dan terpinggirkan lebih rentan mengalami komplikasi. Oleh karena itu, tantangan kesetaraan gender dalam kehamilan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural.

Stigma sosial juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender selama kehamilan. Perempuan hamil yang berusaha bersikap mandiri dalam mengambil keputusan sering kali dianggap melawan norma keluarga atau budaya. Situasi ini menyebabkan banyak perempuan tidak berani menuntut haknya atas layanan kesehatan reproduksi. Menurut Kawakami et al. (2023), stigma sosial yang dilekatkan pada perempuan hamil yang mengalami depresi juga membuat mereka enggan mencari bantuan profesional. Akibatnya, masalah kesehatan mental dalam kehamilan sering kali tidak tertangani dengan baik. Selain itu, ketimpangan informasi antara laki-laki dan perempuan memperburuk kondisi karena banyak perempuan tidak memiliki akses setara terhadap edukasi

kesehatan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam kehamilan membutuhkan pendekatan multidisipliner, melibatkan aspek sosial, budaya, dan kebijakan. Dengan mengatasi tantangan tersebut, kesehatan ibu dapat ditingkatkan secara signifikan.

4. Dampak Ketidaksetaraan Gender terhadap Kesehatan Ibu Hamil

Ketidaksetaraan gender dalam kehamilan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan ibu, baik fisik maupun mental. Perempuan yang tidak memiliki kendali penuh atas keputusan medis berisiko mengalami keterlambatan dalam mendapatkan penanganan komplikasi. WHO (2021) mencatat bahwa tiga penyebab keterlambatan yaitu keterlambatan mengambil keputusan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan mendapatkan pelayanan sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam rumah tangga. Perempuan yang harus menunggu izin suami atau keluarga besar sebelum mencari bantuan medis lebih berisiko mengalami kondisi kritis. Selain itu, kurangnya dukungan finansial membuat mereka sulit menjangkau fasilitas kesehatan berkualitas. Dengan demikian, ketidaksetaraan gender secara signifikan meningkatkan risiko kematian ibu.

Ketidaksetaraan gender juga berdampak pada kesehatan mental ibu hamil. Kurangnya dukungan emosional dari pasangan atau keluarga dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan stres kronis. Kawakami et al. (2023) menekankan bahwa depresi antenatal dapat memengaruhi perkembangan janin, memperbesar risiko persalinan prematur, serta menurunkan kualitas ikatan emosional ibu dan anak. Lebih jauh lagi, perempuan yang mengalami diskriminasi berbasis gender cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah terhadap perawatan medis. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan ibu selama kehamilan. Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan faktor penentu penting dalam mencapai kehamilan yang sehat dan aman. Jika kesetaraan gender tidak diperhatikan, maka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, khususnya target SDGs 3 dan 5, akan sulit terealisasi.

D. Kesenjangan Gender Dalam Persalinan

1. Persalinan sebagai Peristiwa Sosial dan Medis

Persalinan merupakan proses biologis sekaligus peristiwa sosial yang sarat dengan makna budaya, norma, dan relasi gender. Dalam dimensi medis, persalinan memerlukan penanganan profesional untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi. Namun, dalam konteks sosial, pengalaman persalinan sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam keluarga maupun masyarakat. Menurut Bohren et al. (2021), bias gender di ruang bersalin muncul dalam bentuk kurangnya penghormatan terhadap hak perempuan untuk membuat keputusan terkait tubuhnya sendiri. Perempuan kerap ditempatkan sebagai pasien pasif yang hanya mengikuti instruksi tenaga kesehatan. Pandangan ini mengabaikan aspek kesetaraan gender yang menekankan partisipasi aktif perempuan dalam pengalaman reproduktifnya. Dengan demikian, persalinan harus dipandang tidak hanya sebagai proses medis, tetapi juga sebagai momen penting untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Selain itu, persalinan sebagai peristiwa sosial menegaskan keterhubungan antara perempuan, keluarga, dan komunitas. Keputusan mengenai tempat persalinan, jenis bantuan yang digunakan, hingga siapa yang hadir dalam proses tersebut, sering kali dipengaruhi oleh norma budaya dan peran gender. Chou et al. (2022) menekankan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan perspektif gender dapat meningkatkan kualitas pengalaman persalinan. Misalnya, di beberapa negara, pelatihan tenaga kesehatan tentang hak reproduktif perempuan berhasil mengurangi praktik diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial tidak dapat dipisahkan dari aspek medis dalam proses persalinan. Dengan memahami persalinan sebagai kombinasi peristiwa biologis dan sosial, kesetaraan gender dapat lebih terintegrasi dalam praktik pelayanan kesehatan.

2. Partisipasi Suami dan Keluarga dalam Persalinan

Partisipasi suami dan keluarga dalam persalinan merupakan elemen penting untuk menciptakan pengalaman yang lebih aman dan manusiawi bagi perempuan. Kehadiran suami atau keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang signifikan, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan rasa percaya diri ibu saat melahirkan.

Menurut Mutua et al. (2020), dukungan keluarga juga berkaitan dengan keputusan medis yang lebih cepat dalam kondisi darurat, sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi. Namun, dalam praktiknya, banyak rumah sakit yang masih membatasi keterlibatan suami atau keluarga di ruang bersalin dengan alasan teknis maupun budaya. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan gender karena mengabaikan kebutuhan perempuan akan dukungan sosial. Dengan demikian, partisipasi suami dan keluarga seharusnya diakui sebagai bagian dari hak reproduktif perempuan.

Selain dukungan emosional, keterlibatan keluarga juga berfungsi sebagai sarana advokasi bagi perempuan di ruang bersalin. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengalami obstetric violence atau perlakuan tidak manusiawi lebih berani menyuarakan penolakannya ketika didampingi keluarga. Bohren et al. (2021) mencatat bahwa kehadiran pendamping dapat mengurangi risiko terjadinya intervensi medis yang tidak perlu, seperti episiotomi rutin atau induksi tanpa persetujuan. Partisipasi keluarga dengan demikian tidak hanya memberikan dukungan psikologis, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan. Dengan membuka ruang bagi keterlibatan keluarga, layanan persalinan dapat lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Praktik Tradisional dan Budaya yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender

Praktik tradisional dan budaya memiliki peran besar dalam membentuk pengalaman persalinan, baik yang mendukung maupun yang membatasi kesetaraan gender. Di beberapa komunitas, persalinan masih sangat dipengaruhi

oleh dukun bayi atau tradisi turun-temurun yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk pada norma patriarki.

Menurut WHO (2021), praktik tradisional yang tidak berbasis bukti medis dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk perdarahan dan infeksi. Namun, budaya juga dapat berperan positif apabila dipadukan dengan pendekatan kesehatan berbasis hak perempuan. Misalnya, tradisi gotong royong dalam mendampingi ibu melahirkan dapat menjadi bentuk dukungan sosial yang memperkuat kesehatan mental. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya lokal sangat penting agar program kesehatan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengorbankan kesetaraan gender.

Praktik budaya yang bersifat diskriminatif, seperti larangan bagi perempuan untuk menentukan tempat persalinan atau siapa yang akan menolong, sering kali mengekang kemandirian perempuan. Bohren et al. (2021) menunjukkan bahwa pembatasan ini mencerminkan bias gender yang masih melekat dalam sistem kesehatan maupun norma sosial. Sebaliknya, upaya mengintegrasikan praktik budaya positif dengan pelayanan medis telah terbukti meningkatkan tingkat kepuasan ibu melahirkan. Chou et al. (2022) menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang dilatih untuk menghormati nilai budaya sekaligus mengedepankan hak perempuan mampu menciptakan pengalaman persalinan yang lebih adil dan setara. Dengan demikian, budaya tidak boleh dipandang semata-mata sebagai penghalang, tetapi juga sebagai peluang untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam persalinan.

4. Akses dan Hak Perempuan dalam Memilih Proses Persalinan

Kesetaraan gender dalam persalinan menuntut adanya penghormatan terhadap hak perempuan untuk memilih metode persalinan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Hak ini mencakup akses terhadap informasi lengkap, alternatif metode persalinan, serta kebebasan untuk menyetujui atau menolak intervensi medis. Menurut WHO (2021), informed consent merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang harus dijalankan tanpa

diskriminasi gender. Namun, dalam banyak kasus, perempuan masih diabaikan dalam pengambilan keputusan medis, bahkan ketika menyangkut tubuh mereka sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara teori hak reproduktif dan praktik pelayanan kesehatan. Dengan memperkuat kesadaran tentang hak perempuan, akses terhadap layanan persalinan dapat lebih setara.

Selain itu, keterbatasan akses geografis dan ekonomi juga memperparah ketidaksetaraan gender dalam persalinan. Perempuan di daerah terpencil sering kali tidak memiliki pilihan selain melahirkan di rumah tanpa tenaga medis terlatih. Situasi ini meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi akibat komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah. Chou et al. (2022) menemukan bahwa intervensi berbasis komunitas yang menyediakan transportasi darurat dan dukungan finansial dapat meningkatkan akses perempuan terhadap fasilitas bersalin. Dengan demikian, hak perempuan untuk memilih proses persalinan bukan hanya isu etika, tetapi juga persoalan struktural yang membutuhkan kebijakan afirmatif. Kesetaraan gender hanya dapat tercapai apabila semua perempuan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses setara terhadap layanan kesehatan reproduktif.

E. Dampak Ketidaksetaraan Gender dalam Persalinan terhadap Angka Kematian Ibu dan Bayi

Ketidaksetaraan gender dalam persalinan memiliki dampak signifikan terhadap angka kematian ibu dan bayi. Perempuan yang tidak mendapat kesempatan untuk membuat keputusan medis berisiko mengalami keterlambatan dalam penanganan komplikasi, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu. WHO (2021) menekankan bahwa angka kematian ibu yang tinggi di banyak negara berkembang berkaitan erat dengan keterlambatan akses dan ketidaksetaraan gender. Ketika perempuan harus menunggu izin suami atau keluarga sebelum mencari pertolongan medis, risiko perdarahan, eklampsia, atau sepsis meningkat tajam. Hal

ini memperlihatkan bagaimana relasi gender yang timpang dapat berdampak langsung pada keselamatan jiwa perempuan dan bayinya.

Selain kematian ibu, ketidaksetaraan gender juga memengaruhi kesehatan bayi yang baru lahir. Perempuan yang tidak didukung dalam proses persalinan cenderung mengalami stres psikologis yang tinggi, yang dapat berdampak pada kondisi janin. Penelitian Bohren et al. (2021) menunjukkan bahwa perlakuan tidak manusiawi di ruang bersalin dapat meningkatkan risiko trauma persalinan dan berdampak negatif terhadap ikatan ibu-anak. Di sisi lain, intervensi yang menghormati hak perempuan terbukti menurunkan angka morbiditas ibu dan bayi. Chou et al. (2022) menegaskan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam persalinan bukan hanya etis, tetapi juga efektif secara kesehatan masyarakat. Dengan demikian, mengurangi ketidaksetaraan gender dalam persalinan merupakan strategi kunci untuk mencapai target global penurunan angka kematian ibu dan bayi.

F. Kebijakan dan Regulasi

1. Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi dan program yang mendukung kesetaraan gender dalam kesehatan ibu, kehamilan, dan persalinan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara eksplisit menegaskan hak setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang juga berimplikasi pada perlindungan hak perempuan dalam kesehatan reproduksi. Program khusus seperti Gerakan Sayang Ibu (GSI), Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan instrumen kebijakan yang difokuskan pada peningkatan akses layanan persalinan aman dan bermutu (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Namun, meskipun regulasi telah tersedia, banyak daerah masih menghadapi kendala

distribusi tenaga kesehatan dan infrastruktur. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan nasional masih membutuhkan penguatan di level implementasi agar efektif menjawab tantangan kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan ibu (Sari et al., 2023).

2. Kebijakan Global

Di tingkat global, sejumlah lembaga internasional telah menetapkan standar dan rekomendasi untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dalam proses kehamilan dan persalinan. World Health Organization (WHO) memperkenalkan konsep Respectful Maternity Care (RMC) sebagai standar pelayanan bersalin yang menekankan penghormatan terhadap martabat, otonomi, dan hak perempuan (WHO, 2022).

United Nations Population Fund (UNFPA) berfokus pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan layanan antenatal care (ANC) yang berkualitas dan akses universal terhadap tenaga kesehatan terlatih. Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga dan kelima, menekankan pentingnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menghapuskan semua bentuk diskriminasi berbasis gender (United Nations, 2020). Rangkaian kebijakan global ini menjadi kerangka normatif yang dapat dijadikan acuan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk merumuskan strategi nasional. Dengan demikian, kebijakan global memiliki peran penting sebagai standar internasional sekaligus instrumen advokasi dalam mendorong kesetaraan gender di bidang kesehatan reproduksi.

3. Implementasi dan Tantangan di Lapangan

Meskipun kebijakan nasional dan global telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan, khususnya bidan dan tenaga medis di daerah terpencil. Selain itu, faktor budaya patriarki sering kali menghambat partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, sehingga kebijakan yang sudah progresif tidak

sepenuhnya berdampak. Penelitian Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun Jampersal berhasil meningkatkan angka persalinan di fasilitas kesehatan, masih terdapat hambatan berupa rendahnya keterlibatan laki-laki dan kurangnya sosialisasi mengenai hak reproduktif perempuan.

Di sisi lain, resistensi dari sebagian tenaga kesehatan terhadap prinsip Respectful Maternity Care (RMC) juga menjadi tantangan serius (WHO, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh perubahan sikap, nilai, dan budaya kerja di lingkungan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, strategi implementasi harus mencakup dimensi struktural dan kultural secara bersamaan.

4. Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Realita

Kesenjangan antara kebijakan dan realita di lapangan masih menjadi persoalan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender pada kesehatan ibu. Di tingkat regulasi, Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang dan program yang komprehensif, namun penerapan di masyarakat sering kali tidak sesuai dengan tujuan kebijakan. Misalnya, meskipun program KIA dan Jampersal memberikan akses layanan bersalin gratis, perempuan tetap mengalami diskriminasi berupa keterbatasan dalam pengambilan keputusan medis (Sari et al., 2023).

Begitu pula dengan standar global seperti RMC yang sudah direkomendasikan WHO, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik tenaga kesehatan di lapangan (WHO, 2022). Hal ini menunjukkan adanya missing link antara regulasi normatif dan praktik pelayanan sehari-hari. Analisis kesenjangan ini menggarisbawahi bahwa reformasi kebijakan harus disertai dengan pengawasan, pelatihan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat agar tujuan kesetaraan gender benar-benar tercapai. Dengan demikian, transformasi dari kebijakan ke realitas membutuhkan intervensi multi-level yang berfokus pada aspek struktural, budaya, dan pendidikan masyarakat.

G. Strategi dan Intervensi Kesenjangan Gender

1. Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Hamil

Pendidikan dan pemberdayaan perempuan hamil merupakan fondasi utama dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi. Melalui pendidikan kesehatan yang komprehensif, perempuan hamil dapat memahami hak-haknya, mengakses informasi tentang kehamilan, serta membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan diri dan persalinan. Menurut Kabeer (2021), pemberdayaan perempuan bukan hanya menyangkut peningkatan kapasitas individu, tetapi juga transformasi struktur sosial yang memungkinkan perempuan memperoleh posisi tawar lebih baik. Program kelas ibu hamil yang digagas oleh Kementerian Kesehatan, misalnya, terbukti meningkatkan pengetahuan ibu mengenai tanda bahaya kehamilan dan pentingnya antenatal care (ANC).

Selain itu, pemberdayaan perempuan juga mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga perempuan memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan layanan kesehatan. Peningkatan kapasitas ini berkontribusi langsung pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, sekaligus memperkuat kesetaraan gender di tingkat keluarga dan masyarakat (Mutua et al., 2020).

2. Peran Tenaga Kesehatan (Bidan, Dokter, Perawat) dalam Mendorong Kesenjangan Gender

Tenaga kesehatan memegang peranan strategis dalam memastikan prinsip kesetaraan gender terimplementasi di layanan kehamilan dan persalinan. Bidan, dokter, maupun perawat menjadi aktor utama yang bersentuhan langsung dengan ibu hamil, sehingga sikap mereka dapat memengaruhi kualitas pengalaman perempuan dalam mengakses layanan kesehatan. WHO (2022) menekankan pentingnya pelatihan tenaga kesehatan mengenai Respectful Maternity Care (RMC), yang meliputi penghormatan terhadap martabat, privasi, dan persetujuan perempuan dalam setiap tindakan medis. Namun, dalam praktiknya, bias gender masih sering ditemukan, misalnya dalam bentuk

diskriminasi, keputusan medis tanpa persetujuan, atau penggunaan bahasa yang merendahkan. Pelatihan berkelanjutan yang menanamkan nilai kesetaraan gender terbukti mampu meningkatkan kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien (Chou et al., 2022). Dengan demikian, profesionalisme tenaga kesehatan yang responsif gender bukan hanya meningkatkan kepuasan pasien, tetapi juga berkontribusi pada penurunan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.

3. Keterlibatan Suami/Partner dalam Program Antenatal dan Persalinan

Keterlibatan suami atau pasangan dalam kehamilan dan persalinan merupakan strategi penting untuk menciptakan ekosistem kesehatan reproduksi yang lebih setara. Dukungan suami tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mencakup aspek finansial, pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif dalam kunjungan antenatal care. Mutua et al. (2020) menemukan bahwa partisipasi laki-laki dalam perawatan antenatal meningkatkan kepatuhan terhadap konsumsi suplemen, deteksi dini komplikasi, dan penggunaan layanan kesehatan bersalin. Di beberapa negara, kebijakan cuti ayah atau paternal leave juga telah diimplementasikan untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam mendampingi persalinan (United Nations, 2020). Namun, di banyak budaya, keterlibatan suami masih dipandang tabu karena norma patriarki yang menganggap kehamilan sebagai urusan perempuan. Oleh karena itu, program pendidikan komunitas yang menekankan peran suami sebagai mitra aktif sangat diperlukan. Dengan meningkatkan partisipasi laki-laki, proses kehamilan dan persalinan dapat menjadi pengalaman kolektif yang lebih setara dan inklusif.

4. Peningkatan Akses terhadap Layanan Kesehatan Berkualitas

Akses universal terhadap layanan kesehatan berkualitas merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender pada masa kehamilan dan persalinan. Layanan Antenatal Care, persalinan dengan tenaga terlatih, serta rujukan medis yang cepat dan efektif harus dapat dijangkau oleh semua perempuan, tanpa memandang status sosial atau lokasi geografis. Menurut WHO

(2021), salah satu determinan utama tingginya angka kematian ibu adalah keterlambatan dalam mengakses layanan kesehatan akibat hambatan struktural dan gender. Program nasional seperti Jampersal di Indonesia berupaya mengurangi hambatan ekonomi dengan memberikan layanan persalinan gratis, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan (Sari et al., 2023). Selain itu, pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil juga menjadi langkah penting untuk memastikan pemerataan akses. Layanan yang merata dan responsif gender akan memberikan jaminan bahwa perempuan dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman, bermartabat, dan bebas diskriminasi.

5. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi dalam Mendukung Kesetaraan Gender

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi. Aplikasi kesehatan ibu yang berbasis mobile, misalnya, telah digunakan untuk memberikan edukasi, mengingatkan jadwal antenatal care, serta memfasilitasi komunikasi antara ibu hamil, suami, dan tenaga kesehatan. Morrison et al. (2022) menekankan bahwa digital health dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi bias gender dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh perempuan, bahkan di daerah terpencil. Di Indonesia, berbagai aplikasi kesehatan telah dikembangkan untuk mendukung program KIA, meskipun pemanfaatannya masih terbatas pada kelompok tertentu. Selain itu, teknologi telemedicine juga dapat memperluas akses konsultasi medis bagi perempuan yang memiliki keterbatasan mobilitas. Inovasi digital ini semakin relevan di era pandemi, ketika akses layanan tatap muka sering terhambat. Dengan pengembangan teknologi yang inklusif gender, layanan kesehatan dapat lebih merata, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

H. Studi Kasus dan Best Practices

1. Studi Kasus di Indonesia

Di Indonesia, salah satu contoh praktik baik dalam mendorong kesetaraan gender pada layanan kesehatan ibu adalah program **Suami Siaga (Suami Siap Antar Jaga)**. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam mendukung kehamilan dan persalinan dengan cara mendampingi istri ke fasilitas kesehatan, menyiapkan kebutuhan finansial, serta memberikan dukungan emosional. Menurut Putri dan Setyowati (2021), program ini berhasil meningkatkan akses terhadap layanan darurat maternal karena suami lebih siap mengambil keputusan cepat ketika terjadi komplikasi. Selain itu, keterlibatan suami juga terbukti memperkuat ikatan emosional antara pasangan, sekaligus mengurangi risiko keterlambatan dalam rujukan ke fasilitas kesehatan. Studi ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis komunitas yang melibatkan peran laki-laki dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu. Implementasi program serupa juga mulai berkembang di daerah lain, meskipun masih menghadapi hambatan budaya patriarki yang kuat. Dengan demikian, Suami Siaga menjadi salah satu contoh nyata intervensi berbasis gender di Indonesia yang dapat direplikasi secara lebih luas.

2. Praktik Terbaik di Negara Lain

Praktik terbaik terkait kesetaraan gender dalam layanan kehamilan dan persalinan juga dapat ditemukan di berbagai negara. Rwanda, misalnya, berhasil mengintegrasikan layanan kesehatan ibu dengan pendidikan kesetaraan gender melalui kebijakan nasional. WHO (2021) melaporkan bahwa pendekatan ini meningkatkan angka persalinan di fasilitas kesehatan dari 50% menjadi 91% hanya dalam kurun waktu satu dekade. Keberhasilan Rwanda tidak hanya terletak pada peningkatan infrastruktur kesehatan, tetapi juga pada pengarusutamaan gender dalam pendidikan masyarakat dan pelatihan tenaga kesehatan. Sementara itu, Swedia dikenal dengan kebijakan **cuti ayah yang setara** sebagai bagian dari sistem jaminan sosial. Menurut Bergström et al. (2020), kebijakan ini

berkontribusi pada penurunan risiko depresi pascapersalinan pada ibu, sekaligus memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak sejak awal. Praktik di kedua negara tersebut menunjukkan bahwa dukungan struktural melalui kebijakan publik dapat memperkuat kesetaraan gender dalam sistem kesehatan reproduksi.

3. Analisis Perbandingan

Jika dibandingkan, praktik di Indonesia, Rwanda, dan Swedia menunjukkan variasi strategi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Indonesia dengan program Suami Siaga menekankan keterlibatan laki-laki di tingkat komunitas, yang efektif dalam mengatasi hambatan budaya dan meningkatkan kesiapsiagaan keluarga. Rwanda lebih fokus pada pendekatan makro melalui integrasi kebijakan kesehatan dengan pendidikan kesetaraan gender, sehingga dampaknya terlihat pada skala nasional. Sementara itu, Swedia menonjolkan kebijakan berbasis hak melalui cuti ayah, yang menciptakan keseimbangan peran dalam keluarga dan memperbaiki kesehatan mental ibu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam kesehatan ibu dapat dicapai melalui berbagai jalur: pendidikan masyarakat, reformasi kebijakan, maupun dukungan struktural terhadap peran laki-laki. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan strategi bergantung pada kesesuaian dengan kebutuhan lokal, sekaligus adanya komitmen politik untuk menghapus hambatan gender dalam sistem kesehatan (WHO, 2021; Bergström et al., 2020; Putri & Setyowati, 2021).

I. Simpulan

Kesetaraan gender dalam kehamilan dan persalinan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang optimal. Ketidaksetaraan gender terbukti berdampak negatif terhadap akses layanan kesehatan, kualitas perawatan, hingga kesejahteraan psikososial ibu hamil dan melahirkan. Sebaliknya, keterlibatan aktif laki-laki, dukungan tenaga kesehatan, serta regulasi yang responsif gender dapat memperkuat kualitas pengalaman

kehamilan dan persalinan. Kesetaraan gender juga berkontribusi terhadap pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs)**, terutama tujuan 3 (kesehatan) dan tujuan 5 (kesetaraan gender), yang menjadi indikator global pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak boleh dipandang semata sebagai isu perempuan, tetapi sebagai isu keluarga, masyarakat, dan negara. Upaya pengaruh utama gender di bidang kesehatan reproduksi dapat menciptakan dampak positif tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, keluarga, dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam kehamilan dan persalinan merupakan investasi penting bagi generasi mendatang.

J. Referensi

- Bergström, M., Wells, M. B., & Johansson, M. (2020). The impact of gender-equal parental leave on maternal health outcomes in Sweden. *Scandinavian Journal of Public Health*, 48(5), 543–550.
- Bhatt, N., Bhatt, B., & Gurung, R. (2022). Gender inequality and maternal health: Systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22 (1), 812.
- Bohren, M. A., Vogel, J. P., Hunter, E. C., et al. (2021). Mistreatment of women during childbirth: A systematic review. *The Lancet Global Health*, 9(6), e712–e729.
- Chou, D., Daelmans, B., Jolivet, R. R., & Kinney, M. (2022). Respectful maternity care for all women. *Reproductive Health*, 19(1), 1–7.
- George, A. S., Amin, A., García-Moreno, C., & Sen, G. (2020). Gender equality and health: Reviewing evidence on health inequalities. *Health Policy and Planning*, 35(2), 113–126.
- Kabeer, N. (2021). Gender equality, health, and development. *Feminist Economics*, 27(2), 1–24.
- Kawakami, C., Yoshida, K., & Suzuki, T. (2023). Partner support and maternal mental health during pregnancy. *Journal of Affective Disorders*, 329, 232–241.

- Khan, Z., Bhutta, Z. A., & Darmstadt, G. L. (2020). Gender and health: Global perspectives. *The Lancet*, 396(10249), 521–522.
- Morrison, J., Tumbahangphe, K., & Budhathoki, S. (2022). Gender-responsive healthcare in maternal services. *BMJ Global Health*, 7(9), e009432.
- Mosha, I. H., Ruben, R., & Sangeda, R. Z. (2021). Male involvement in antenatal care. *PLOS ONE*, 16(3), e0248437.
- Mutua, M. M., Kimani, M., & Njuki, R. (2020). Male partner involvement in antenatal care. *BMC Public Health*, 20, 77.
- Putri, D., & Setyowati, S. (2021). Male involvement in maternal health in Indonesia. *International Journal of Reproductive Health*, 15(2), 45–56.
- Ravindran, T. K. S., Balasubramanian, P., & Jain, S. (2022). Community-based interventions for maternal health. *Global Public Health*, 17(7), 1345–1361.
- Sari, N., Pratiwi, R., & Widodo, T. (2023). Gender equity in maternal health policy in Indonesia. *Health Policy and Planning*, 38(4), 345–357.
- Shannon, G., Jansen, M., Williams, K., Cáceres, C., Motta, A., Odhiambo, A., Eleveld, A., & Mannell, J. (2019). Gender equality in science, medicine, and global health: Where are we at and why does it matter? *The Lancet*, 393(10171), 560–569.
- Sileo, K. M., Wanyenze, R. K., & Kiene, S. M. (2020). Masculinity and men's involvement in maternal healthcare in Uganda. *Culture, Health & Sexuality*, 22(8), 910–925.
- UN Women. (2020). Gender equality in health. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/gender-equality-in-health>
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2021). State of world population 2021: My body is my own. UNFPA.

WHO. (2021). Gender equality and maternal health. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240029607>

WHO. (2022). Standards for respectful maternity care. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240050465>

WHO. (2023). Improving maternal and newborn health and survival and reducing stillbirth. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240079323>

K. Glosarium

AKI	= Angka Kematian Ibu
ANC	= Antenatal Care
GSI	= Gerakan Sayang Ibu
SDGs	= Sustainable Development Goals
RMC	= Respectful Maternity Care
UNFPA	= United Nations Population Fund
<i>WHO</i>	= <i>World Health Organization</i>

CHAPTER 3

KESETARAAN GENDER PADA PEREMPUAN LANSIA

Ngatemi, S.Si.T., MKM.

A. Pendahuluan/Prolog

Meningkatnya angka harapan hidup membuat proporsi penduduk lanjut usia terus bertambah dan, di banyak negara termasuk Indonesia, mayoritas kelompok ini adalah perempuan. Fenomena “feminisasi penuaan” tersebut membawa konsekuensi kebijakan yang besar, karena perempuan lansia tidak hanya menua, tetapi menua dengan jejak panjang ketidaksetaraan yang mereka alami sejak kecil: akses pendidikan yang lebih terbatas, peluang kerja formal yang lebih sempit, beban kerja domestik yang tak dibayar, hingga norma gender yang mengurangi suara mereka dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan yang menumpuk sepanjang daur kehidupan itu bermuara pada kerentanan ganda ketika usia bertambah, saat kesehatan mulai menurun, jejaring dukungan berubah, dan kebutuhan sosial-ekonomi meningkat. Karena itu, kesetaraan gender pada perempuan lansia bukan sekadar tema tambahan dalam kebijakan kependudukan, melainkan prasyarat agar penuaan penduduk berjalan inklusif, adil, dan bermartabat.

Dari sisi sosial, banyak perempuan memasuki usia lanjut dengan identitas yang selama puluhan tahun dilekatkan pada peran pengasuhan dan kerja rumah tangga. Ketika anak-anak beranjak mandiri dan peran domestik menurun intensitasnya, tidak selalu tersedia kanal partisipasi baru yang setara di komunitas. Norma patriarkal masih kerap memposisikan perempuan lansia sebagai “penerima bantuan” alih-alih warga yang berdaya dan berpengalaman. Akibatnya, mereka kurang dilibatkan dalam musyawarah keluarga, forum warga, atau organisasi komunitas; ruang publik terasa lebih jauh, sementara lingkaran sosial menyempit.

Isolasi sosial, rasa tak dianggap, dan menyusutnya jejaring dukungan menjadi masalah yang nyata, terlebih pada mereka yang tinggal sendiri, menyandang disabilitas, atau mengalami hambatan mobilitas. Di sisi lain, tidak sedikit perempuan lansia tetap memikul tanggung jawab pengasuhan cucu atau merawat pasangan/orang tua sangat lanjut, tetapi kerja perawatan yang melelahkan ini sering tidak diakui dan jarang mendapat dukungan formal.

Ketimpangan ekonomi yang terakumulasi juga paling terasa di usia lanjut. Riwayat bekerja di sektor informal, jeda karier karena kehamilan dan pengasuhan, serta upah yang lebih rendah selama masa produktif membuat perempuan lansia lebih berisiko miskin. Banyak yang memasuki usia tua tanpa tabungan memadai, tanpa pensiun, dan dengan aset yang terbatas—sering kali karena tanah atau rumah atas nama suami/keluarga besar. Ketika menjadi janda, bercerai, atau merantau mengikuti anak, posisi tawar ekonomi melemah; di sejumlah komunitas, hak waris perempuan masih tersisih oleh praktik adat. Kerentanan finansial ini bertemu dengan biaya kesehatan yang meningkat, ongkos transportasi yang tak murah, serta kebutuhan alat bantu (kacamata, alat bantu jalan) yang tak selalu terjangkau. Di wilayah pedesaan dan kepulauan, jarak ke fasilitas layanan dan pasar kerja informal yang mengecil memperparah kesenjangan.

Dimensi kesehatan memperlihatkan tantangan khas perempuan lansia. Risiko penyakit tidak menular—hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker—meningkat seiring usia, sementara kondisi yang lebih lazim pada perempuan seperti osteoporosis, nyeri sendi, dan sindrom urogenital memengaruhi gerak, rasa nyaman, dan kualitas hidup. Aspek kesehatan mental kerap luput: duka berulang, kesepian, dan tekanan peran dapat menumbuhkan depresi dan kecemasan, tetapi gejalanya sering disalahartikan sebagai “wajar karena tua”. Hambatan akses layanan—biaya, jarak, arsitektur gedung yang tidak ramah lansia, jam praktik yang tidak fleksibel—berkelindan dengan bias gender di fasilitas kesehatan, misalnya anggapan bahwa keluhan nyeri atau masalah seksual lansia tidak penting. Padahal, pelayanan geriatri yang peka gender, yang memadukan penatalaksanaan medis dengan dukungan

psikososial serta edukasi keluarga, terbukti meningkatkan kemandirian dan menekan biaya jangka panjang.

Budaya dan keyakinan lokal ikut membentuk pengalaman menua. Di sebagian masyarakat, perempuan lansia dipandang sebagai “beban” atau sosok yang di ruang privat saja, sehingga suaranya memudar di ruang publik. Di tempat lain, mereka dihormati sebagai penjaga nilai dan pengetahuan. Perbedaan narasi ini memengaruhi seberapa besar ruang yang diberi untuk belajar, bersuara, dan berkarya di usia lanjut. Stigma berbasis usia (ageism) sering bertemu stigma berbasis gender, menciptakan diskriminasi berlapis: candaan yang merendahkan fisik lansia perempuan, penilaian moral pada perempuan yang ingin aktif kembali di ekonomi, atau minimnya representasi lansia perempuan dalam media dan lembaga. Pada kasus ekstrem, ketimpangan dan stigma membuka jalan bagi kekerasan terhadap lansia ekonomi, psikologis, bahkan fisik yang kerap tersembunyi di balik dinding rumah.

Di tengah tantangan tersebut, tersimpan potensi besar yang sering tak terlihat. Perempuan lansia menyimpan modal sosial, kearifan lokal, dan keterampilan perawatan yang dapat menjadi penyangga komunitas—dari ketahanan pangan rumah tangga, pengasuhan lintas generasi, hingga mediasi konflik. Ketika diberi akses pada pembelajaran sepanjang hayat, peluang ekonomi mikro, dan teknologi digital yang ramah lansia, mereka dapat tetap produktif, mandiri, dan terhubung. Karena itu, agenda kesetaraan gender pada perempuan lansia menuntut pendekatan lintas sektor: penguatan perlindungan sosial yang sensitif gender, perluasan layanan kesehatan yang ramah usia dan inklusif, perbaikan tata ruang dan transportasi publik, serta pendidikan literasi keuangan dan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia.

Kesetaraan di usia lanjut juga mensyaratkan pembenahan tata kelola di tingkat keluarga hingga negara. Di keluarga, pembagian peran perawatan yang lebih adil dan komunikasi antargenerasi yang menghargai pilihan lansia akan mengurangi beban tersembunyi perempuan. Di komunitas, pelibatan lansia perempuan dalam

perencanaan desa/kelurahan dan program berbasis warga akan menumbuhkan rasa memiliki dan mengikis stereotip. Di ranah kebijakan, sistem pensiun dan bantuan sosial perlu memastikan jangkauan terhadap pekerja informal yang mayoritas perempuan; kerangka hukum waris/pertanahan harus mengukuhkan hak kepemilikan perempuan; indikator layanan kesehatan dan kesejahteraan mesti terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur agar ketimpangan terbaca dan bisa diperbaiki.

B. Konsep Kesenjangan Gender dan Lansia

Kesenjangan gender pada dasarnya berarti pengakuan bahwa perempuan dan laki laki memiliki harkat, hak, dan peluang yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, menikmati hasil pembangunan, serta terlindungi dari diskriminasi. Dalam tradisi hak asasi modern, kesetaraan dipahami pada dua tingkat. Pertama, kesetaraan formal yang menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua, kesetaraan substantif yang memastikan hasil dan pengalaman hidup juga setara melalui penghapusan hambatan yang tidak kasatmata serta penyediaan dukungan khusus agar kelompok yang tertinggal dapat mengejar ketertinggalannya. Pada kelompok lansia, terutama perempuan, kesetaraan substantif menjadi kunci, sebab ketidaksetaraan yang dialami tidak hanya lahir dari perbedaan gender, tetapi juga dari usia, status sosial ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan kondisi disabilitas. Kombinasi ini sering membuat perlakuan yang tampak netral gagal menghasilkan keadilan.

Dalam perspektif global, kerangka kesetaraan gender bersandar pada sejumlah instrumen dan inisiatif internasional. Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan menegaskan kewajiban negara untuk menghapus hambatan di semua ranah kehidupan perempuan, dari pendidikan dan kerja hingga kesehatan dan partisipasi politik. Agenda pembangunan berkelanjutan memperkuat mandat ini melalui tujuan tentang kesetaraan gender, pengurangan ketimpangan, dan hidup sehat untuk semua usia. Kerangka penuaan yang disepakati komunitas internasional

menempatkan martabat, kemandirian, partisipasi, dan perlindungan sebagai prinsip yang harus dijamin bagi warga lanjut usia. Organisasi kesehatan dunia menyuarakan Dekade Penuaan Sehat yang menekankan peluang merata untuk mempertahankan kemampuan fungsional sambil melawan ageisme, yaitu prasangka yang didasarkan pada usia. Seluruh rujukan global itu menyatu pada satu pesan, yaitu kesetaraan pada usia lanjut bukan kebijakan belas kasih, melainkan pemenuhan hak.

Pada tingkat nasional, konsep kesetaraan gender lazim dioperasionalkan melalui pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan. Intinya adalah memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di seluruh sektor mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki laki di setiap kelompok umur. Ini mencakup penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin dan umur, analisis kesenjangan, desain program yang peka gender, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Di saat yang sama, kebijakan tentang lanjut usia menggariskan perlindungan, pemberdayaan, dan partisipasi lansia di keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika dua arus ini disatukan, muncullah kerangka kerja yang lebih tajam, yaitu kesetaraan gender yang peka usia, sehingga suara dan kebutuhan perempuan di atas usia enam puluh tahun tidak lagi larut dalam rata rata populasi.

Menghubungkan kesetaraan gender dengan kondisi khusus perempuan lansia memerlukan lensa daur kehidupan. Banyak perempuan memasuki usia lanjut setelah puluhan tahun mengalami upah yang lebih rendah, jeda karier untuk pengasuhan, kerja domestik yang tidak dibayar, serta akses terbatas pada pendidikan dan pelatihan. Akumulasi ini menghasilkan celah pensiun, minimnya aset atas nama sendiri, serta ketergantungan finansial pada pasangan atau anak. Pada saat yang sama, janda, perempuan yang hidup sendiri, atau yang tinggal di daerah terpencil menghadapi risiko isolasi sosial yang lebih tinggi. Dengan lensa daur kehidupan, kebijakan kesetaraan tidak berhenti pada generasi muda, tetapi mengoreksi ketidakadilan yang terbawa sampai usia lanjut dan sering kali baru tampak sepenuhnya di masa tua.

Aspek kesehatan melengkapi gambaran ini. Perempuan lansia lebih sering berhadapan dengan osteoporosis, nyeri sendi, gangguan urogenital, dan kondisi kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang. Isu kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan meningkat ketika dukungan sosial menyusut atau beban perawatan keluarga justru bertambah. Kesetaraan gender dalam kesehatan berarti layanan geriatri yang tanggap gender, konsultasi yang menghormati otonomi, penanganan nyeri dan fungsi seksual yang tidak dianggap tabu, serta akses yang adil pada alat bantu dan terapi. Kesetaraan juga berarti menghapus bias yang menganggap keluhan perempuan lansia sebagai sesuatu yang “wajar karena usia”, dan menggantinya dengan standar klinis yang serius, berempati, dan berbasis bukti.

Pembedaan antara kesetaraan dan keadilan atau equity penting untuk ditegaskan. Kesetaraan memberi hak yang sama, sedangkan keadilan memberi dukungan berbeda agar hasilnya setara. Perempuan lansia mungkin membutuhkan afirmasi agar setara dalam praktik, misalnya prioritas untuk layanan rumah kunjungan bagi yang mobilitasnya terbatas, sesi penyuluhan yang dijadwalkan sesuai ritme kerja rumah tangga, pelatihan literasi digital yang pelan dan berulang, serta kanal pengaduan yang ramah usia. Di ranah ekonomi, keadilan dapat berupa pensiun sosial minimum yang menjangkau pekerja informal, program kewirausahaan mikro dengan pendampingan yang sabar, dan layanan bantuan hukum untuk memperkuat hak waris dan kepemilikan aset perempuan lanjut usia.

Konsep kesetaraan gender juga tidak dapat dipisahkan dari partisipasi bermakna. Perempuan lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat program, melainkan harus hadir dalam proses perumusan kebijakan, mulai dari forum desa hingga perencanaan kota dan penganggaran daerah. Partisipasi bermakna mensyaratkan akses informasi yang dapat dipahami, ruang dialog yang inklusif secara fisik dan sosial, serta moderator yang peka terhadap dinamika antargenerasi. Ketika lansia perempuan dilibatkan sebagai narasumber pengalaman, program menjadi lebih realistis, penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, dan rasa memiliki terhadap kebijakan meningkat.

Agar konsep kesetaraan gender benar benar bekerja untuk lansia perempuan, tata kelola data yang baik tidak bisa dinegosiasikan. Data terpilah menurut jenis kelamin, umur, lokasi, disabilitas, dan status sosial ekonomi adalah syarat untuk melihat siapa yang tertinggal. Indikator tidak boleh hanya menghitung jumlah penerima bantuan, tetapi juga mengukur hasil yang dirasakan, seperti perbaikan mobilitas, penurunan kesepian, bertambahnya kontrol atas pengeluaran rumah tangga, atau meningkatnya keikutsertaan dalam forum komunitas. Dengan cara ini, pemerintah dan mitra dapat menilai apakah kebijakan yang tampak setara di atas kertas benar benar berbuah setara dalam kenyataan.

Dimensi budaya menuntut kejelian tersendiri. Kesetaraan gender pada lansia perempuan sering terhambat oleh stigma yang merendahkan nilai perempuan setelah fungsi reproduksi berhenti. Konsep kesetaraan yang peka budaya tidak bermakna menuruti stigma, melainkan berdialog dengan nilai lokal untuk menegaskan martabat dan kontribusi lansia perempuan dalam bahasa yang dapat diterima komunitas. Narasi publik yang menyoroti peran mereka sebagai penjaga pengetahuan, pengikat keluarga, dan pelopor solidaritas dapat melunakkan resistensi dan membuka ruang perubahan. Literasi hukum dan kesehatan yang dibungkus dalam tradisi setempat sering lebih efektif daripada kampanye yang serba teknis.

Pada ranah rumah tangga, konsep kesetaraan menampilkan wajah yang sangat praktis. Pembagian kerja perawatan antara anggota keluarga, keputusan bersama tentang tempat tinggal dan penggunaan aset, serta komunikasi terbuka mengenai keintiman dan kesehatan pada usia lanjut adalah wujud kesetaraan yang paling dekat dengan keseharian. Ketika keluarga menempatkan lansia perempuan sebagai subjek keputusan, bukan objek belas kasih, kualitas hidup meningkat dan konflik teredam. Kebijakan publik dapat memperkuat hal ini melalui layanan jeda bagi keluarga perawat, konseling keluarga lintas generasi, dan dukungan komunal yang meringankan biaya perawatan.

C. Dinamika Peran Sosial Perempuan Lansia

Memasuki usia lanjut tidak sekadar berarti bertambah umur, melainkan mengubah konfigurasi peran yang selama puluhan tahun membentuk identitas perempuan. Pergeseran ini terjadi serentak di ruang keluarga, komunitas, dan dunia kerja, serta selalu dinegosiasikan dengan norma budaya dan nilai tradisi yang hidup di sekitarnya. Di dalam keluarga, banyak perempuan lansia berpindah dari peran pengasuh anak menjadi pengasuh cucu atau anggota keluarga sakit. Ada yang menjadi penopang utama rumah tangga setelah ditinggal pasangan, ada pula yang berbagi fungsi dengan anak yang telah berkeluarga. Pada keluarga multigenerasi, perempuan lansia sering menjadi poros emosional, pengelola ritus, dan pengingat nilai. Peran sebagai penjaga tradisi tidak hanya berarti menyiapkan hidangan atau memimpin doa keluarga, tetapi juga menjadi rujukan keputusan harian, seperti pola asuh cucu, penataan keuangan rumah tangga, atau pilihan layanan kesehatan. Namun fungsi ini tidak otomatis memberi kuasa. Di banyak rumah, otoritas formal tetap berada pada generasi yang lebih muda atau figur laki laki, sementara perempuan lansia menjalankan kerja perawatan yang berat tetapi kurang terlihat, termasuk menenangkan konflik, mengisi kekosongan pengasuhan ketika anak menempuh pekerjaan berjam kerja panjang, dan merawat kerabat yang sakit menahun.

Peran pengasuhan pada usia lanjut membawa dua wajah. Di satu sisi, ia menghadirkan makna dan kedekatan lintas generasi. Di sisi lain, ia dapat menimbulkan kelelahan yang tidak kecil, terlebih ketika diiringi keterbatasan mobilitas atau penyakit kronis. Perempuan lansia yang menjadi kepala keluarga tunggal menghadapi beban tambahan, seperti mengelola pemasukan yang tidak stabil, menjaga rumah, dan menegosiasikan bantuan dari sanak saudara. Pada lingkungan yang masih memegang kuat hierarki usia dan jenis kelamin, suara perempuan tua dihormati sebagai petuah. Namun pada lingkungan lain, terutama yang sangat menekankan otoritas pencari nafkah laki laki, pendapat perempuan lansia dapat dikesampingkan, bahkan untuk urusan yang menyentuh tubuh dan

kesehatannya sendiri. Di sinilah tampak bagaimana tradisi bisa menjadi penopang atau justru pagar yang membatasi ruang gerak.

Dalam masyarakat, peran sosial perempuan lansia bergerak di antara pengakuan dan pengaburan. Tidak sedikit komunitas yang melihat mereka sebagai penjaga kearifan, penghubung generasi, dan penjaga kohesi. Pada acara adat, pernikahan, kelahiran, dan upacara keagamaan, tangan perempuan lansia yang menyiapkan tata laku, merapikan simbol, dan menenangkan kegaduhan sering menjadi syarat kelancaran ritus. Mereka memelihara resep, pantang, dan praktik yang menyatukan keluarga besar. Di sisi lain, ageisme yang menyatu dengan bias gender membuat sebagian perempuan lansia dianggap “selesai” dalam ruang publik. Kesempatan tampil sebagai narasumber, pengurus lembaga warga, atau pengambil keputusan di tingkat lokal sering lebih kecil dibandingkan laki laki sebaya. Ruang pertemuan yang tidak ramah mobilitas, bahasa rapat yang terlalu teknis, dan jadwal yang tidak peka akan ritme harian lansia membuat partisipasi kian sulit. Meski begitu, ketika forum difasilitasi dengan inklusif, perempuan lansia membawa perspektif yang kaya pengalaman hidup, terutama tentang pengelolaan krisis rumah tangga, ketahanan pangan keluarga, serta cara membangun solidaritas pada saat-saat genting.

Di dunia kerja, dinamika peran dipengaruhi sejarah kerja sepanjang hayat. Perempuan yang pernah bekerja di sektor formal cenderung memasuki masa pensiun dengan aturan yang jelas, tetapi tidak selalu dengan dukungan ekonomi yang cukup karena upah seumur hidup dan masa iur yang lebih pendek. Banyak perempuan lain menghabiskan sebagian besar hidup di sektor informal, usaha mikro, atau kerja perawatan yang tidak dibayar. Ketika tua, mereka tetap mencari penghasilan melalui berdagang kecil, jasa rumahan, kerajinan, atau pertanian skala keluarga. Aktivitas ini menjaga rasa mampu dan relasi sosial, tetapi rentan pada fluktuasi pasar dan kesehatan. Norma budaya memberi warna tambahan. Di lingkungan yang mengapresiasi kemandirian ekonomi, perempuan lansia dipuji sebagai ulet. Di lingkungan yang memuja kesunyian perempuan tua, upaya mereka

berbisnis dapat dipandang tidak pantas atau “terlalu ambisius.” Penilaian moral semacam ini mempengaruhi dukungan keluarga terhadap kegiatan ekonomi lansia, misalnya soal penggunaan ruang rumah, akses modal kecil, atau izin menggunakan gawai untuk berjualan.

Urbanisasi dan migrasi memperumit, sekaligus membuka celah baru. Perempuan lansia yang tinggal di kota kerap kehilangan jejaring tradisional tetapi memperoleh akses ke kegiatan komunitas, pusat lansia, kelas kebugaran, dan layanan kesehatan. Mereka yang tinggal di desa mungkin lebih kaya dukungan keluarga, namun terkendala transportasi dan fasilitas. Dalam keluarga migran, perempuan lansia bisa menjadi jangkar rumah bagi cucu ketika orang tua bekerja di kota lain atau luar negeri. Mereka mengelola rumah tangga lintas jarak, menjaga ritme sekolah cucu, dan menjadi penerima remitansi yang bertugas mengalokasikan belanja keluarga. Peran yang tampak “tradisional” ini sesungguhnya sangat strategis, tetapi jarang masuk dalam peta kebijakan. Sementara itu, perempuan lansia yang ikut bermigrasi untuk membantu anak juga berhadapan dengan adaptasi budaya baru, hambatan bahasa, dan ketergantungan administratif yang membuat posisi tawar mereka di rumah tangga melemah.

Teknologi menggeser lanskap peran dengan cepat. Akses telepon pintar, aplikasi pesan, dan media sosial memberi peluang bagi perempuan lansia untuk menjaga silaturahmi, berjualan, belajar, dan berpartisipasi dalam forum warga tanpa harus meninggalkan rumah. Bagi yang akrab dengan teknologi, ruang digital menjadi perpanjangan tangan dari peran sosialnya. Namun bagi banyak lainnya, jurang literasi digital menciptakan ketergantungan pada anak cucu, memicu rasa tertinggal, atau bahkan membuka risiko penipuan dan penyalahgunaan data. Norma keluarga ikut menentukan. Ada keluarga yang mendorong nenek memegang ponsel sendiri, mengajarnya langkah demi langkah, dan menganggapnya setara sebagai pengguna. Ada pula yang memandang perangkat digital “tidak perlu” untuk perempuan tua, sehingga menutup satu kanal partisipasi yang kian penting pada masa kini.

Kekuatan norma adat dan nilai tradisi terlihat nyata dalam isu hak atas aset dan keputusan tempat tinggal. Dalam sistem yang patrilineal, perempuan lansia yang menjadi janda bisa kehilangan hak menggarap tanah karena aset diklaim keluarga suami. Dalam sistem yang lebih egaliter atau matrilineal, lansia perempuan justru menjadi pemegang keputusan penting terkait lahan dan rumah, meski tetap dibatasi oleh tata cara adat. Perbedaan ini mempengaruhi kemampuan mereka menentukan perawatan kesehatan, berbagi sumber daya dengan cucu, dan menegosiasikan bantuan dari anak. Di sejumlah tempat, norma juga mengatur peluang menikah kembali, yang bagi perempuan tua sering dinilai tidak pantas sehingga mempersempit pilihan hidup, sementara bagi laki-laki tua lebih diterima. Norma semacam itu membentuk pengalaman keseharian yang sangat konkret, dari hak menggunakan ruang privat hingga siapa yang berhak mengundang rapat keluarga.

Perubahan peran juga tampak dalam konteks krisis. Saat terjadi bencana, pandemi, atau guncangan ekonomi, perempuan lansia sering muncul sebagai simpul pertolongan pertama di lingkungan terdekat. Mereka memasak massal, mengatur distribusi barang, memantau yang sakit, dan menjaga anak ketika orang tua harus keluar rumah. Di saat bersamaan, mereka adalah kelompok rentan yang membutuhkan akses prioritas pada layanan kesehatan, bantuan pangan, dan dukungan psikososial. Ketegangan antara menjadi pemberi bantuan dan penerima bantuan ini menunjukkan betapa fleksibelnya peran perempuan lansia. Mereka mengisi celah yang ditinggalkan sistem, tetapi kekuatan ini tidak boleh menutupi kebutuhan mereka sendiri. Pengalaman krisis juga memperlihatkan bahwa ketika perempuan lansia dilibatkan dalam perencanaan kesiapsiagaan, peta risiko menjadi lebih tajam karena mereka mengetahui dengan rinci siapa yang lemah, rute evakuasi yang realistis, serta sumber daya lokal yang dapat digerakkan cepat.

Pada tataran individu, semua dinamika tadi bermuara pada negosiasi identitas. Perempuan lansia menata ulang rasa diri di persimpangan “memberi” dan “menerima”, antara “diandalkan” dan “perlu ditopang”. Sementara kesehatan dan energi tidak lagi sekuat dulu, pengalaman hidup memberi mereka modal sosial dan

kebijaksanaan yang tidak bisa disubstitusi. Ada yang memilih memperluas peran publik melalui organisasi keagamaan, koperasi, atau kelompok senam. Ada yang memusatkan perhatian pada keluarga inti dan menemukan kepuasan dalam ritme domestik yang lebih tenang. Ada pula yang kembali belajar, mengajar, atau berkarya seni. Kebebasan menentukan pilihan inilah inti kesetaraan di usia lanjut. Ia menuntut lingkungan yang menghormati keputusan perempuan, menyediakan dukungan bila dibutuhkan, dan tidak mengukur nilai diri semata dari produktivitas ekonomi.

D. Akses Perempuan Lansia terhadap Layanan Kesehatan

Akses perempuan lansia terhadap layanan kesehatan tidak hanya diukur dari keberadaan fasilitas, melainkan dari apakah layanan itu benar benar dapat dicapai, diterima, dimanfaatkan, dan dirasakan manfaatnya oleh mereka. Pada kenyataannya, jalur menuju layanan kerap terjal karena pertemuan antara bias berbasis usia dan bias berbasis gender. Keduanya membentuk kesenjangan yang tampak di ruang praktik klinik, di meja administrasi asuransi, dalam arsitektur gedung yang tidak ramah mobilitas, sampai pada nada bahasa yang menyiratkan bahwa keluhan perempuan tua “wajar saja” sehingga tidak perlu ditangani serius. Kesenjangan ini paling kentara di tiga ranah: layanan geriatri, kesehatan reproduksi pada usia lanjut, dan kesehatan mental.

Dalam layanan geriatri, kebutuhan perempuan lansia sering kali lebih kompleks. Mereka hidup lebih lama, lebih sering menyandang penyakit kronis ganda, dan lebih rentan mengalami penurunan fungsi fisik seperti sarkopenia dan gangguan keseimbangan. Namun penilaian geriatri komprehensif yang semestinya menjadi pintu masuk, meliputi status fungsional, nutrisi, kognisi, suasana hati, dukungan sosial, risiko jatuh, serta tinjauan obat, belum menjadi praktik rutin di banyak layanan primer. Alih alih memeriksa keseluruhan konteks, keluhan dipilah per organ dan diobati satu per satu sehingga polypharmacy terjadi dan efek samping saling bertumpuk. Perempuan membawa spektrum keluhan yang khas seperti nyeri sendi persisten, inkontinensia, dan fragilitas tulang, tetapi keterbatasan

alat bantu, ruang tunggu tanpa kursi sandar, serta waktu konsultasi yang singkat membuat eksplorasi kebutuhan fungsional tertunda. Hambatan finansial memperkeras jurang. Perempuan yang sepanjang hidup bekerja di sektor informal sering tidak memiliki jaminan pensiun atau hak atas manfaat kesehatan yang memadai; kontribusi mereka dalam kerja perawatan rumah tangga yang tak dibayar tidak tercermin dalam skema pembiayaan. Di daerah pedesaan atau kepulauan, persoalan jarak, ongkos transportasi, dan terbatasnya tenaga geriatri membuat pemeriksaan lanjutan nyaris mustahil. Ketika akses fisik terbuka, akses informasi belum tentu menyusul. Bahasa medis yang kaku, brosur bertulisan kecil, dan penjelasan yang terburu-buru menutup ruang untuk pertanyaan praktis, misalnya menata rumah agar aman dari jatuh atau menyusun ulang jadwal minum obat yang sudah terlalu padat.

Kesehatan reproduksi pada usia lanjut kerap disalahpahami sebagai urusan yang sudah berakhir, padahal lansia perempuan masih memerlukan layanan yang spesifik dan bermartabat. Sindrom urogenital pascamenopause dengan gejala kekeringan, nyeri saat berhubungan, urgensi dan frekuensi berkemih meningkat, serta infeksi saluran kemih berulang sering dianggap aib atau dianggap tidak layak dibahas. Akibatnya, banyak perempuan menahan nyeri dan menghindari keintiman, lalu kualitas relasi terganggu dan harga diri terkikis. Keluhan prolaps organ panggul, inkontinensia, dan gangguan dasar panggul lain membutuhkan fisioterapi, alat bantu, atau intervensi bedah yang aman, namun rujukan ke fisioterapis dasar panggul jarang ditawarkan. Layanan skrining kanker yang adaptif usia juga belum merata. Perempuan lanjut usia memerlukan penilaian individual tentang manfaat dan risiko skrining kanker payudara, leher rahim, dan kolorektal, tetapi keputusan sering diambil secara generik tanpa mempertimbangkan harapan hidup, fungsi harian, dan preferensi pasien. Sementara itu, isu kesehatan seksual lansia hampir tak pernah mendapat tempat. Ketika perempuan bertanya tentang pelumas atau perubahan respons seksual, jawabannya sering minim atau bernada moral, padahal intervensi sederhana dan aman bisa sangat membantu. Di sisi lain, sebagian

perempuan lansia tetap aktif secara seksual dan tidak boleh diasumsikan bebas risiko infeksi menular seksual. Tanpa edukasi yang sensitif dan nonmenghakimi, deteksi dini dan pengobatan infeksi akan terlambat. Semua ini menunjukkan bahwa hambatan akses bukan hanya perkara fasilitas, tetapi juga perkara rasa aman untuk membuka topik yang dianggap tabu.

Kesehatan mental adalah bidang lain di mana perempuan lansia menghadapi penghalang berlapis. Duka berulang, peralihan peran, kesepian, dan kelelahan sebagai pengasuh cucu atau pasangan sakit dapat memicu depresi dan kecemasan, sementara gejala tersebut kerap ditenggelamkan dalam label “pikun” atau “rewel karena tua”. Layanan primer jarang menyisipkan skrining singkat depresi, kecemasan, dan risiko kekerasan terhadap lansia pada kunjungan rutin. Ketika bantuan psikologis dibutuhkan, rujukan menuju psikolog klinis atau psikiater terhambat oleh keterbatasan tenaga, biaya, dan stigma. Konseling kelompok atau pendampingan sebaya yang bisa menjadi jembatan kerap tidak tersedia, terutama di luar kota besar. Dalam konteks demensia, akses perempuan terhadap penilaian kognitif yang layak dan intervensi non farmakologis masih timpang. Banyak yang datang ketika fungsi sudah turun jauh karena keluarga baru menyadari perubahan setelah terjadi insiden, misalnya tersesat atau jatuh. Dukungan bagi keluarga perawat, yang juga banyak diemban perempuan lansia terhadap pasangan, jarang terstruktur sehingga beban emosional memuncak dan risiko kelelahan perawat meningkat.

Kesenjangan gender dalam akses juga terbentuk dari cara desain layanan memandang tubuh dan pengalaman perempuan. Keluhan nyeri kronis, kelelahan, dan gangguan tidur sering dipandang tidak mendesak sehingga prioritas antrean jatuh ke kasus yang dianggap lebih nyata secara biomedis. Waktu konsultasi yang sempit membuat cerita yang berlapis, biologi, psikologis, sosial, tidak sempat digali. Di banyak tempat, layanan dirancang tanpa memperhitungkan kebutuhan privasi perempuan lansia yang datang bersama anggota keluarga laki laki; keputusan tentang tubuh dan rumah tangga mudah bergeser dari tangan pasien ke tangan

pendamping. Hambatan bahasa dan literasi memperlebar jarak. Perempuan yang menggunakan bahasa daerah atau memiliki kemampuan baca terbatas akan tersisih bila konseling hanya mengandalkan brosur standar. Di wilayah minoritas atau komunitas adat, perbedaan nilai mengenai penuaan, penyakit, dan seksualitas membutuhkan pendekatan yang peka budaya agar perempuan merasa dihormati, bukan dihakimi.

Teknologi memberi peluang sekaligus ujian bagi keadilan akses. Telemedisin, edukasi melalui gawai, dan pengingat minum obat berbasis pesan singkat bisa mengurangi jarak dan ongkos, namun celah literasi digital, kepemilikan perangkat, dan kekhawatiran privasi dapat membuat sebagian perempuan tertinggal. Ketika keluarga menguasai perangkat milik lansia, kerahasiaan keluhan, terutama terkait keintiman, kekerasan, atau kesehatan mental, terancam. Desain layanan digital yang baik harus menyediakan antarmuka sederhana, pilihan audio bagi yang kesulitan membaca, ikon yang tidak mencolok, serta kanal aman untuk berkonsultasi tanpa kehadiran anggota keluarga bila pasien menghendaki. Pada sisi pembiayaan, pengakuan tindakan konseling jarak jauh dan terapi non farmakologis dalam paket manfaat akan menentukan apakah inovasi ini menjadi jembatan atau justru menambah kesenjangan.

Menutup kesenjangan akses menuntut perubahan di tiga tingkat sekaligus. Pada tingkat klinis, setiap kontak layanan primer sebaiknya memadukan penilaian fungsional, skrining kesehatan mental, dan ruang aman untuk membahas isu urogenital serta seksualitas. Bahasa yang digunakan konkret dan menghormati otonomi, hasil konsultasi ditutup dengan rencana tindak lanjut yang ditulis jelas agar dapat dibawa pulang dan dibaca ulang bersama keluarga. Pada tingkat organisasi layanan, arsitektur fisik dan alur pendaftaran perlu ramah lansia: kursi yang nyaman, toilet aksesibel, pencahayaan yang cukup, antrean prioritas, serta waktu praktik yang membuka opsi pagi atau sore. Jejaring rujukan ke fisioterapis dasar panggul, psikolog klinis, dan konselor keluarga harus aktif, bukan sekadar daftar nomor. Di tingkat kebijakan, perlindungan sosial yang menjangkau pekerja informal, yang

mayoritas perempuan, akan memotong hambatan biaya. Data terpilah menurut jenis kelamin, umur, disabilitas, dan lokasi perlu menjadi dasar alokasi sumber daya agar wilayah yang tertinggal mendapat perhatian. Kampanye publik yang menormalisasi pembicaraan tentang kesehatan seksual lansia, depresi pada lanjut usia, dan hak atas perawatan yang bermartabat akan mengikis rasa malu yang selama ini membuat perempuan menunda berobat.

Akses yang adil pada akhirnya berarti layanan yang bertemu dengan kehidupan nyata perempuan lansia. Ia hadir dekat rumah melalui posyandu lansia, kunjungan rumah, atau klinik bergerak yang terjadwal; ia bicara dalam bahasa yang mereka pahami; ia menyentuh hal yang paling mengganggu hari hari mereka, bukan sekadar angka laboratorium. Layanan seperti ini mengakui perempuan lansia sebagai subjek yang cakap mengambil keputusan, menyediakan dukungan ketika mereka ingin melibatkan keluarga, dan membuka jalur privat ketika mereka butuh ruang sendiri. Ketika keadilan akses terwujud di geriatri, kesehatan reproduksi lanjut usia, dan kesehatan mental, kualitas hidup tidak lagi bergantung pada kebetulan, melainkan menjadi buah dari tata layanan yang dirancang untuk menghormati martabat perempuan sampai usia berapa pun.

E. Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Kesenjangan ekonomi bagi perempuan lansia bertumpu pada satu pertanyaan besar yang sangat praktis: apakah di usia tua mereka memiliki sumber penghidupan yang aman, terkendali, dan layak sehingga dapat hidup bermartabat tanpa bergantung secara total pada belas kasihan orang lain. Jawabannya kerap rumit karena ekonomi usia lanjut tidak berdiri sendiri. Ia adalah hasil akumulasi keputusan, peluang, dan hambatan sepanjang daur kehidupan. Perempuan lebih sering mengalami jeda kerja karena hamil, melahirkan, dan mengasuh. Mereka lebih banyak terkonsentrasi di pekerjaan rumah tangga atau usaha mikro yang tidak tercatat. Upah seumur hidup lebih rendah, jam kerja fleksibel yang tidak diakui, serta

kerja perawatan yang tidak dibayar membuat tabungan dan iuran jaminan sosial mereka tipis. Ketika memasuki usia lanjut, akumulasi kesenjangan itu berubah menjadi jurang. Banyak perempuan tiba di masa tua tanpa pensiun, aset atas nama sendiri, atau perlindungan sosial yang memadai.

Kemandirian finansial di usia lanjut karenanya sulit dicapai bila instrumen dasarnya tidak disiapkan sejak awal. Bagi perempuan yang pernah bekerja di sektor formal, pensiun ada tetapi sering kecil karena masa iur terpotong jeda pengasuhan dan struktur upah yang lebih rendah. Bagi yang bekerja di sektor informal, mayoritas tidak pernah tercakup dalam skema pensiun dan asuransi sosial. Di pedesaan dan wilayah kepulauan, perempuan lansia menggantungkan hidup pada usaha tani skala rumah tangga, berdagang kecil, atau jasa domestik yang pendapatannya tidak menentu. Ketika menjadi janda atau hidup sendiri, risiko kemiskinan meningkat tajam. Kemandirian finansial yang bermakna dalam situasi semacam ini memerlukan campuran aset yang realistis. Tabungan mikro yang aman dan mudah diakses, kepemilikan rumah atau lahan yang jelas status hukumnya, keterampilan untuk mempertahankan pendapatan kecil namun stabil, serta akses ke layanan perbankan yang ramah lansia. Banyak perempuan lansia tidak memiliki dokumen identitas lengkap atau rekening atas nama sendiri sehingga tertutup akses pada bantuan tunai, kredit produktif, atau asuransi. Persoalan ini tampak kecil di atas kertas, tetapi menjadi penentu apakah seorang nenek bisa menerima bantuan pangan bulanan, memperbaiki atap rumah, atau membeli obat untuk penyakit kronis.

Perlindungan sosial menjadi jangkar ketika pasar kerja dan keluarga tidak lagi memadai. Skema bantuan tunai lansia yang tidak bergantung iuran memberikan jaring pengaman minimum bagi mereka yang seumur hidup bekerja di sektor informal. Nilainya harus realistis terhadap biaya hidup dan diindeks agar tidak terkikis inflasi. Di samping itu, pensiun iuran bagi pekerja informal dengan iuran ringan dan skema top up dari negara membuka jalan agar pekerja rumahan, pedagang kecil, dan buruh harian perempuan dapat membangun hak pensiun setahap demi setahap. Manfaat turut hidup bagi janda dan penyintas perceraian

penting agar perempuan tidak jatuh miskin ketika pasangan berpulang atau rumah tangga bubar. Di luar transfer uang, perlindungan sosial yang sensitif gender mencakup dukungan pangan, perbaikan rumah sederhana, layanan utilitas bersubsidi, serta bantuan alat bantu seperti kacamata, alat bantu dengar, dan tongkat. Mekanisme penyaluran juga menentukan. Antrian panjang yang melelahkan, lokasi pencairan yang jauh, atau persyaratan administrasi yang rumit sering menjadi penghalang yang tidak terlihat. Penyaluran digital memangkas biaya, tetapi tanpa pendampingan literasi, ia bisa memindahkan masalah dari kantor pos ke layar ponsel.

Pensiun bukan sekadar angka bulanan. Ia adalah struktur yang menyimpan banyak bias halus. Rumus manfaat yang tidak mengakui jeda pengasuhan menghukum perempuan yang keluar masuk pasar kerja karena merawat. Penyesuaian inflasi yang lambat menurunkan daya beli lansia lebih cepat daripada statistik resmi. Usia pensiun yang seragam tanpa opsi fleksibel dapat tidak adil bagi pekerja perempuan di sektor fisik yang berat. Pembenahan membutuhkan keberanian merancang ulang. Kredit pengasuhan yang mengakui tahun merawat anak atau orang tua sebagai masa iur, opsi pensiun fleksibel yang tidak menghukum mereka yang ingin tetap bekerja paruh waktu, serta jaminan pensiun minimum agar tidak ada yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, portabilitas manfaat penting bagi perempuan yang berpindah kerja atau lokasi mengikuti dinamika rumah tangga. Tanpa portabilitas, hak pensiun tercecer dan tidak pernah menjadi manfaat nyata.

Diskriminasi gender di ranah ekonomi tidak berhenti ketika usia kerja berakhir. Ia bergeser bentuk. Di pasar kerja, perempuan lansia kerap dialihkan ke tugas yang kurang bernilai atau didorong keluar dengan alasan efisiensi. Di usaha mikro, akses pemasaran dan modal lebih sering mengalir kepada pengusaha laki laki yang dipandang lebih bankable. Ketika ingin memulai usaha kecil di usia tua, perempuan berhadapan dengan syarat agunan, biaya administrasi, dan penilaian risiko yang tidak menimbang modal sosial serta reputasi lokal yang mereka miliki. Tindakan

hukum dan kebijakan perlu menutup celah ini. Perlindungan dari diskriminasi usia di tempat kerja, pelatihan ulang yang dirancang ramah lansia, serta skema pembiayaan mikro dengan pendampingan yang sabar dan biaya wajar memungkinkan perempuan tetap produktif tanpa terperosok dalam jerat kredit konsumtif yang menyesakkan arus kas.

Hak atas aset menjadi simpul lain yang menentukan. Di banyak keluarga, rumah dan lahan masih atas nama suami atau keluarga besar. Ketika suami meninggal, hak pakai perempuan dapat dipertanyakan oleh kerabat. Sengketa kecil yang tidak tercatat dapat berujung pada terusirnya perempuan dari rumah yang ia tempati puluhan tahun. Program sertifikasi tanah bersama, kemudahan balik nama untuk janda, dan literasi hukum waris yang praktis memberi payung bagi perempuan lansia untuk tetap tinggal aman. Aset yang aman bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga soal kontrol atas keputusan. Rumah yang atas nama sendiri membuat perempuan lebih leluasa mengatur perbaikan kecil, menerima tamu layanan kesehatan di rumah, atau memutuskan tinggal bersama siapa tanpa ketakutan kehilangan tempat tinggal.

Perempuan lansia juga rentan terhadap kekerasan ekonomi dan penipuan. Penawaran investasi yang tidak masuk akal, pinjaman daring berbunga sangat tinggi, atau pengambilalihan aset oleh anggota keluarga dengan dalih perwalian adalah bentuk kekerasan yang sering berlindung di balik kepercayaan. Pencegahan memerlukan kombinasi edukasi yang mudah dipahami, kanal pengaduan yang responsif, serta penegakan hukum yang berpihak pada korban. Layanan keuangan yang ramah lansia menurunkan risiko, misalnya dua lapis verifikasi untuk transaksi besar, peringatan penipuan yang jelas di loket dan aplikasi, serta prosedur mudah untuk memblokir sementara rekening saat muncul kecurigaan penyalahgunaan. Di tingkat komunitas, kelompok arisan dan simpan pinjam berbasis warga dapat menjadi ruang aman belajar dan saling mengingatkan, selama tata kelolanya transparan dan didampingi.

Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup lebih dari uang. Biaya kesehatan kronis, kebutuhan perawatan jangka panjang, serta beban pengasuhan cucu menyedot energi dan tabungan. Skema pembiayaan kesehatan yang melindungi dari biaya besar, layanan perawatan di rumah dan komunitas dengan biaya terjangkau, serta tunjangan kecil bagi keluarga perawat mengurangi tekanan yang sering berakhir pada jual aset atau utang berbunga tinggi. Perempuan lansia yang menjadi pengasuh utama membutuhkan istirahat terjadwal, pelatihan merawat yang tepat, dan akses ke dukungan psikologis. Tanpa itu, kelelahan emosional berubah menjadi sakit fisik, dan lingkaran kemiskinan mempererat cengkeramannya.

Transformasi digital membuka peluang yang tidak boleh dibiarkan lewat. Platform dagang memberi pasar baru bagi keterampilan anyaman, kuliner, atau jasa kecil. Dompet digital memudahkan penerimaan remitansi dan bantuan sosial tanpa biaya perjalanan. Namun manfaat ini hanya nyata jika ada literasi digital yang sabar dan berulang, perangkat yang benar benar dimiliki sendiri, serta layanan pelanggan yang siap membantu ketika terjadi kesalahan. Perempuan lansia perlu dibukakan pintu ke ekonomi platform tanpa dijebak oleh algoritme yang sering tidak ramah pekerja berusia. Regulasi yang menjamin keselamatan kerja, transparansi upah, dan akses jaminan sosial bagi pekerja platform usia lanjut akan mencegah inovasi menjadi wajah baru dari eksploitasi.

F. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Perempuan Lansia

Pembahasan tentang perlindungan hukum bagi perempuan lansia berangkat dari kesadaran bahwa hak asasi manusia tidak berakhir ketika seseorang menua. Justru pada tahap inilah akumulasi ketidaksetaraan berbasis gender yang dialami sejak muda sering muncul paling jelas dalam wujud kemiskinan di usia tua, keterbatasan akses kesehatan, kehilangan hak atas aset, hingga kekerasan dan penelantaran. Tugas kerangka hukum adalah memastikan hak itu tetap utuh dan dapat digunakan, bukan sekadar tercatat di atas kertas. Untuk itu, peta perlindungan perlu dilihat berlapis, mulai dari komitmen internasional, kebijakan nasional, sampai

mekanisme operasional yang benar benar dirasakan di ruang praktik layanan dan di dalam rumah tangga.

Pada tingkat global, fondasi normatifnya tegas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bersama dua kovenan induk tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya mengafirmasi hak atas martabat, kesehatan, jaminan sosial, perumahan, dan perlindungan dari diskriminasi untuk setiap orang sepanjang hayat. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menempatkan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan de jure dan de facto dalam pendidikan, kerja, kesehatan, hingga kehidupan keluarga. Instrumen ini diperkuat oleh rekomendasi umum yang secara khusus menyoroti hak perempuan usia lanjut dan menuntut langkah afirmatif melawan diskriminasi berlapis yang lahir dari pertemuan usia dan gender. Di ranah penuaan, Prinsip PBB untuk Lansia menggarisbawahi lima pilar yaitu kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan martabat, sementara Rencana Aksi Internasional Madrid tentang Penuaan meminta negara memasukkan penuaan sehat dalam strategi pembangunan, memerangi ageisme, dan memastikan partisipasi lansia dalam pengambilan keputusan. Dekade Penuaan Sehat yang dipimpin organisasi kesehatan dunia menambahkan dimensi operasional melalui empat agenda besar yaitu perubahan cara pandang terhadap penuaan, komunitas ramah lansia, layanan terintegrasi dan berpusat pada individu, serta perawatan jangka panjang yang dapat diandalkan. Di atas semua itu, komunitas internasional melalui agenda pembangunan berkelanjutan menautkan isu lansia ke target kesetaraan gender, pengurangan ketimpangan, kesejahteraan, dan kota inklusif. Satu catatan penting tetap perlu dikemukakan, dunia belum memiliki konvensi khusus yang mengikat tentang hak lansia. Proses menuju instrumen semacam itu terus berlanjut, sekaligus menjadi pengingat bahwa negara perlu mengisi kekosongan melalui kebijakan domestik yang lebih tajam terhadap lansia perempuan.

Kerangka nasional yang kuat memulai perlindungan dari konstitusi dan undang undang hak asasi yang menolak diskriminasi serta menjamin kesetaraan di

hadapan hukum. Di banyak yurisdiksi, ada undang undang yang secara khusus mengatur kesejahteraan atau perlindungan lanjut usia, menetapkan tugas negara dan pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan sosial, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan kesempatan partisipasi. Pengakuan atas hak sosial ekonomi juga hadir melalui sistem jaminan sosial nasional yang meliputi kesehatan, jaminan hari tua atau pensiun, serta jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Di wilayah keluarga, undang undang perkawinan yang menegaskan prinsip kesetaraan suami istri dan konsep harta bersama menjadi payung penting bagi janda agar tidak kehilangan hak atas tempat tinggal dan aset produktif ketika pasangan meninggal. Peraturan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana kekerasan seksual memberikan instrumen perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual yang juga dialami lansia perempuan, termasuk mekanisme perintah perlindungan dan akses pada bantuan medis, psikologis, dan bantuan hukum. Bagi perempuan lansia penyandang disabilitas, undang undang disabilitas menuntut akomodasi yang layak pada layanan publik, transportasi, dan lingkungan binaan sehingga akses tidak berhenti di ambang pintu gedung. Dalam ranah prosedural, undang undang bantuan hukum memastikan kelompok miskin dan rentan mendapatkan pendampingan tanpa biaya, sementara lembaga pengawas pelayanan publik serta komisi nasional hak asasi membuka kanal pengaduan bila terjadi pelanggaran.

Perlindungan yang terlihat solit dari luar dapat melemah pada fase implementasi jika tidak menyentuh medan faktual lansia perempuan. Itulah mengapa standar layanan dan peraturan pelaksana menjadi jembatan krusial. Di sektor kesehatan, pedoman layanan geriatri yang mewajibkan penilaian menyeluruh mencakup aspek fungsional, kognitif, suasana hati, nutrisi, risiko jatuh, dan telaah obat perlu dijalankan di layanan primer, bukan hanya di rumah sakit. Standar pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut harus menyatakan bahwa isu nyeri saat berhubungan, kekeringan vagina, inkontinensia, prolaps organ panggul, serta hak atas informasi dan penanganan yang bermartabat bukan topik terlarang. Di

kesehatan mental, protokol skrining depresi, kecemasan, dan demensia yang terintegrasi dengan mekanisme rujukan serta dukungan bagi keluarga perawat akan mengubah hak di atas kertas menjadi pengalaman layanan yang nyata. Di ranah perawatan jangka panjang, standar akreditasi untuk panti atau layanan berbasis komunitas, perlindungan pekerja perawat informal, dan prosedur perlindungan dari penelantaran menjadi pagar penting agar perempuan lansia tidak tersisih di tempat yang mestinya aman.

Hak atas jaminan sosial memerlukan desain pembiayaan yang sensitif terhadap riwayat kerja perempuan. Rumus manfaat pensiun yang menghukum jeda pengasuhan akan selalu berakhir tidak adil. Beberapa negara memperkenalkan kredit pengasuhan, yakni perhitungan masa iur pengganti untuk tahun tahun mengasuh anak atau merawat anggota keluarga, sehingga hak pensiun perempuan tidak tergerus. Pensiun non iuran bagi lansia miskin menjadi jangkar minimum yang mencegah kemiskinan ekstrem, sedangkan opsi pensiun fleksibel dan kerja paruh waktu yang dilindungi memberi ruang bagi perempuan lansia yang masih ingin bernilai secara ekonomi tanpa memforsir kesehatan. Kebijakan waris dan pertanahan yang memudahkan balik nama bagi janda, sertifikasi tanah atas nama bersama, serta pembuktian kepemilikan yang tidak memberatkan adalah senjata paling efektif mencegah terusirnya perempuan dari rumah atau lahan yang selama ini ia kelola.

Satu bidang yang kerap diabaikan adalah akses terhadap keadilan. Hambatan bisa muncul sejak dini, misalnya tidak memiliki dokumen identitas yang valid, sulit transportasi ke pengadilan, atau tidak paham prosedur. Proses peradilan yang tidak peka usia dan gender, seperti ruang tunggu tanpa kursi memadai, pemeriksaan yang lama dan berulang, serta bahasa hukum yang rumit, akan mematahkan semangat melapor. Rekomendasi internasional tentang akses keadilan bagi perempuan menyarankan layanan terpadu yang memudahkan pelaporan, pemeriksaan ramah korban, penggunaan pendamping atau juru bahasa, serta opsi mediasi yang benar benar sukarela pada sengketa perdata seperti waris atau perumahan. Paralegal

komunitas terbukti menjadi jembatan efektif, khususnya di pedesaan, untuk membantu perempuan lansia memahami haknya, menyiapkan dokumen, dan menavigasi birokrasi. Sementara itu, petugas kepolisian, petugas kesehatan, dan pekerja sosial membutuhkan pelatihan berkala mengenai kekerasan pada lansia, kekerasan ekonomi, serta penipuan yang menasar perempuan tua agar respon pertama tidak menyalahkan korban.

Perlindungan hukum juga harus bergerak mengikuti perkembangan pola risiko baru. Digitalisasi membawa peluang sekaligus ancaman. Penipuan keuangan, pencurian data, dan manipulasi persetujuan dapat merampas aset lansia perempuan dalam hitungan menit. Kerangka perlindungan konsumen digital dan perlindungan data pribadi perlu memastikan verifikasi berlapis yang mudah digunakan, pemberitahuan risiko yang jelas, kanal pemulihan yang cepat, serta sanksi efektif bagi pelaku. Pada layanan telekesehatan, persetujuan tindakan medis harus diambil secara sadar, privasi dijaga, dan pilihan konsultasi tatap muka tetap tersedia bagi mereka yang tidak nyaman menggunakan perangkat. Prinsip pengambilan keputusan yang didukung, alih alih perwalian yang membatasi, sejalan dengan semangat hak asasi untuk memastikan otonomi perempuan lansia terjaga walau membutuhkan bantuan teknis.

Di tingkat budaya dan komunitas, hukum sering kali baru bekerja ketika ia mampu berdialog dengan nilai setempat. Program penyadaran hak perempuan lansia yang dibalut dalam bahasa dan simbol lokal akan lebih diterima daripada kampanye serba teknis. Kader komunitas, pemimpin agama, dan organisasi perempuan dapat berfungsi sebagai amplifier untuk menegaskan bahwa hak atas kesehatan, waris, dan bebas dari kekerasan bukan milik generasi muda semata, dan bahwa merawat diri di usia lanjut bukan bentuk egoisme, melainkan bagian dari tanggung jawab keluarga untuk menjaga keberlanjutan. Pendekatan ini efektif untuk memadamkan stigma yang menahan perempuan membicarakan nyeri saat berhubungan, inkontinensia, atau depresi, serta melunakkan resistensi terhadap peran publik perempuan lansia di forum desa dan organisasi warga.

Akhirnya, perlindungan hukum yang kuat harus bisa diukur. Negara dan daerah membutuhkan indikator yang memperlihatkan apakah perempuan lansia benar benar terlindungi, bukan sekadar tercakup program. Persentase lansia perempuan yang memiliki identitas hukum dan rekening atas nama sendiri, kepemilikan rumah atas nama perempuan, cakupan pensiun dan bantuan sosial, angka kekerasan dan penyelesaiannya, cakupan skrining kesehatan yang relevan, serta proporsi keluhan layanan publik yang diselesaikan dengan memuaskan adalah contoh ukuran yang berbicara. Data harus terpilah menurut jenis kelamin, umur, lokasi, disabilitas, dan status sosial ekonomi agar ketimpangan yang tersembunyi terlihat. Mekanisme akuntabilitas seperti penganggaran responsif gender dan usia, audit layanan ramah lansia, serta forum konsultasi rutin dengan kelompok lansia perempuan akan menjaga agar kebijakan tidak melenceng dari kebutuhan nyata.

Perlindungan hukum dan hak asasi bagi perempuan lansia pada hakikatnya adalah tentang meneguhkan otonomi dan martabat. Ia menuntut perpaduan antara standar global yang memberi arah, regulasi nasional yang memberi kepastian, dan praktik layanan yang memberi rasa aman. Ketika hak atas kesehatan dipenuhi dengan layanan yang sensitif gender dan usia, hak atas jaminan sosial dinikmati melalui skema yang mengakui kerja pengasuhan, hak atas aset dipastikan melalui administrasi yang sederhana dan adil, serta hak bebas dari kekerasan dijaga melalui respon cepat dan adil, barulah perempuan lansia dapat menua tanpa rasa takut. Kerangka hukum yang hidup seperti itu bukan hanya cermin peradaban, melainkan investasi yang memperkuat keluarga, menumbuhkan kepercayaan publik, dan membangun masyarakat yang memuliakan warganya di setiap tahap kehidupan.

G. Tantangan Budaya dan Stigma Gender pada Lansia

Pandangan budaya tentang menjadi tua selalu hadir dalam dua wajah. Di satu sisi, perempuan lansia dipuji sebagai penjaga tradisi, pengikat keluarga, dan sumber petuah. Di sisi lain, mereka sering ditempatkan pada posisi yang pasif, bergantung,

bahkan tidak lagi dianggap relevan di ruang publik. Ketegangan antara penghormatan simbolik dan pengurangan peran nyata inilah yang melahirkan serangkaian stereotip dan stigma yang membayangi kehidupan perempuan pada usia lanjut. Stigma tersebut tidak lahir dari usia saja, melainkan dari persilangan antara usia dan gender. Kombinasi ini membuat perempuan lansia lebih rentan dibandingkan laki laki seusia mereka terhadap pengaburan peran, pengawasan moral, serta pengambilalihan keputusan atas tubuh dan harta.

Stereotip paling umum adalah penyempitan identitas perempuan pada fungsi reproduksi dan pengasuhan. Begitu fungsi biologis berhenti, nilai sosial mereka dianggap menurun. Dalam percakapan sehari hari, perempuan tua kerap digambarkan sebagai sosok yang rewel, pelupa, lamban, dan tidak mampu mengikuti perubahan. Candaan yang menertawakan rambut beruban, kulit keriput, dan tubuh yang berubah tampak ringan, namun mengirim pesan bahwa penuaan perempuan identik dengan kehilangan daya tarik dan kegunaan. Tekanan ini menyusup ke pilihan pakaian, cara berjalan, bahkan cara berbicara. Banyak perempuan lansia memilih berdiam diri dalam forum keluarga atau warga karena khawatir dinilai memalukan bila pendapatnya dianggap ketinggalan zaman. Mereka membatasi diri bukan karena tidak punya sesuatu untuk disampaikan, tetapi karena norma yang hidup menegur siapa yang pantas bicara dan siapa yang sebaiknya diam.

Di ranah keintiman dan kesehatan seksual, stigma bekerja lebih keras. Topik kekeringan dan nyeri saat berhubungan, infeksi saluran kemih yang berulang, atau penurunan gairah masih dipandang tabu. Perempuan lansia yang berusaha mencari pertolongan sering bertemu dua dinding sekaligus, yaitu rasa malu pribadi yang lahir dari internalisasi norma dan sikap layanan yang menganggap keluhan tersebut tidak penting karena usia. Hasilnya adalah penghindaran, kualitas relasi menurun, dan rasa bersalah yang tidak perlu. Pada kasus lain, sebagian perempuan tetap aktif secara seksual tetapi tidak mendapat edukasi tentang pencegahan infeksi menular seksual karena dianggap mustahil terjadi pada usia mereka. Pandangan yang

menafikan hak perempuan tua atas kenyamanan tubuh dan hubungan setara itu mereduksi martabat, sebab martabat salah satunya terwujud dalam kebebasan berbicara jujur tentang kebutuhan intim tanpa takut dihakimi.

Stigma juga menempel pada status perkawinan. Janda lansia di sejumlah komunitas dipandang sebagai sosok yang seharusnya mengabdikan pada keluarga besar dan menjaga reputasi rumah tangga dengan cara menutup diri dari relasi baru. Ketika memilih menikah kembali, penilaian moral mudah muncul, sementara pilihan yang sama bagi laki-laki lansia lebih diterima. Di beberapa tempat, gosip tentang janda dikaitkan dengan perebutan harta atau pengganggu rumah tangga orang, yang berujung pada pengucilan halus. Pengawasan sosial semacam ini berdampak langsung pada rasa aman, jaringan pertemanan, dan kebebasan bergerak. Lebih jauh lagi, perempuan lansia yang kehilangan pasangan sering turut kehilangan hak atas rumah atau lahan karena adat atau administrasi kepemilikan yang menempatkan aset atas nama suami. Di sini stigma berkelindan dengan ketidakadilan hukum, dan martabat terluka bukan hanya oleh kata-kata, tetapi oleh hilangnya tempat berteduh.

Dalam keluarga multigenerasi, perempuan lansia memikul ekspektasi yang bertentangan. Mereka diharapkan selalu tersedia untuk merawat cucu, memasak, menjaga rumah, dan mendampingi anggota keluarga yang sakit, sekaligus diingatkan agar tidak mencampuri urusan keputusan besar yang dianggap wilayah generasi produktif dan figur laki-laki. Ketika kelelahan atau sakit, permintaan berhenti sering direspons dengan tuduhan tidak ikhlas atau membebani. Peran perawatan yang panjang dan tidak dibayar membuat banyak perempuan lansia menunda perawatan kesehatannya sendiri. Mereka memilih membeli susu untuk cucu ketimbang obat nyeri lutut, menunda konsultasi saat telinga mulai berkurang pendengarannya, dan menutup mata pada gejala depresi karena takut dicap lemah. Kualitas hidup menyusut perlahan melalui serangkaian pengorbanan kecil yang tidak diakui.

Di ruang publik, ageisme berjumpa bias gender dalam bentuk penghilangan kehadiran. Pengurus warga, forum keagamaan, dan panitia acara sering mengajak perempuan lansia bekerja di belakang layar, tetapi jarang menempatkan mereka sebagai pengarah agenda. Ketika berbicara, komentar dibingkai sebagai cerita masa lalu, bukan pengetahuan yang berguna untuk memecahkan masalah hari ini. Media memperkuat pola ini dengan representasi yang menempatkan lansia perempuan sebagai sosok lucu atau rapuh, sementara lansia laki laki tetap diperankan sebagai bijak dan berwibawa. Pesan implisitnya jelas, yaitu otoritas di usia tua masih lebih mudah dilekatkan pada laki laki. Representasi semacam ini mempengaruhi cara institusi memandang kemampuan perempuan lansia, dari perekrutan relawan, pembagian pelatihan kewirausahaan mikro, hingga pemilihan narasumber di televisi lokal.

Stigma budaya juga bekerja melalui bahasa. Sapaan yang meremehkan, panggilan sayang yang bernada mengasuh, dan komentar improvisasi tentang tubuh yang berubah mengikis rasa kompeten. Perempuan lansia sering diperlakukan seperti anak kecil di fasilitas pelayanan, dokumen diambil alih, keputusan diwakilkan tanpa diminta, dan penjelasan medis diarahkan kepada pendamping laki laki. Pola infantilisasi ini menghapus otonomi. Ketika otonomi menyempit, martabat ikut menipis, karena martabat berakar pada kemampuan memilih dan didengar. Di sisi lain, ada keluarga dan komunitas yang menempatkan perempuan tua dalam takhta simbolik sebagai "tetua adat", tetapi tidak membekalinya dengan akses nyata pada informasi, pelatihan, atau sumber daya. Penghormatan tanpa kuasa praktis akhirnya menjadi bentuk lain dari pengabaian yang terlihat indah.

Tidak semua wilayah memanggul beban stigma yang sama. Di komunitas yang menegaskan solidaritas dan nilai gotong royong, perempuan lansia dihargai karena ketekunan menjaga ritus, menjaga anak tetangga, dan menjadi penengah konflik rumah tangga. Namun bahkan di lingkungan yang hangat sekalipun, perubahan sosial cepat dapat memunculkan ketegangan baru. Migrasi anak ke kota besar

membuat perempuan lansia menjadi penyangga rumah tangga lintas jarak, tetapi sekaligus meningkatkan kesepian di waktu senggang. Teknologi digital membuka jendela dunia dan peluang ekonomi, tetapi jurang literasi digital memunculkan stigma baru bahwa perempuan tua tidak mampu belajar. Ketika keluarga memegang ponsel lansia dan mengatur semua akun, pilihan bicara privat dengan tenaga kesehatan atau mengelola uang bantuan menjadi terbatas. Stigma lama tentang ketidakcakapan bertemu kontrol teknis, dan kebebasan menyempit di layar tanpa disadari.

Dampak seluruh stigma itu nyata dan berlapis. Secara psikologis, perempuan lansia yang terus menerus menerima sinyal bahwa dirinya kurang berguna atau mengganggu akan lebih mudah mengalami cemas dan murung. Mereka menarik diri dari pertemuan warga, menolak undangan menari atau senam, dan berhenti meminta bantuan ketika sakit. Secara sosial, jaringan pertemanan mengecil dan ruang aman berkurang, sehingga perlindungan terhadap kekerasan atau penipuan melemah. Secara ekonomi, stigma menutup akses pada pelatihan kecil, kredit mikro, atau kesempatan menjual keterampilan yang sebenarnya mereka miliki. Secara kesehatan, tabu dan rasa malu menunda konsultasi atas keluhan urogenital atau depresi, yang sebenarnya dapat ditangani bila dibicarakan lebih awal. Dan secara hukum, stigma tentang peran perempuan di rumah tangga menghalangi keberanian untuk menuntut hak tanah atau waris, atau melaporkan kekerasan ekonomi yang dilakukan anggota keluarga.

Yang paling berbahaya adalah ketika stigma di luar berubah menjadi suara di dalam. Perempuan lansia dapat menginternalisasi penilaian negatif sehingga meyakini dirinya memang tidak pantas meminta pertolongan atau mengambil peran. Mereka menolak tawaran belajar karena takut menjadi bahan tertawaan, menahan pendapat dalam rapat karena khawatir menyulitkan, dan membiarkan keputusan penting diambil orang lain dengan alasan tidak ingin merepotkan. Internalitas ini menciptakan lingkaran malas yang menyusutkan ruang gerak dari hari ke hari. Padahal, banyak penelitian lapangan menunjukkan bahwa begitu

perempuan lansia diberi ruang yang aman dan bahasa yang membebaskan, mereka bersedia dan mampu berbagi pengetahuan, mengatur kegiatan, dan berjejaring untuk kesejahteraan bersama.

Menantang stigma tentu membutuhkan kebijakan dan layanan, tetapi ia juga merupakan kerja budaya. Cara keluarga bercakap, cara media menarasikan penuaan, cara pemuka agama menafsirkan penghormatan kepada yang tua, dan cara tenaga layanan menyapa pasien menentukan apakah perempuan lansia merasa dihargai atau ditinggalkan. Martabat tumbuh ketika seseorang diberi nama, didengar, dan dipercaya untuk memutuskan. Kualitas hidup meningkat ketika dukungan praktis ditingkatkan sebagai hak, bukan belas kasihan. Selama norma yang menyempitkan peran masih dibiarkan, perempuan lansia akan terus berjalan dengan beban yang tidak perlu. Begitu norma itu diubah melalui percakapan yang jujur dan kebiasaan kecil yang konsisten, perempuan pada usia berapa pun dapat berdiri tegak dan memilih arah hidupnya dengan kepala terangkat.

H. Pemberdayaan Perempuan Lansia

Pemberdayaan perempuan lansia berangkat dari gagasan sederhana tetapi mendasar, yaitu bahwa pengalaman panjang, jejaring sosial, dan kearifan yang mereka bawa adalah modal pembangunan yang selama ini kurang diakui. Strategi pemberdayaan yang efektif tidak menjadikan lansia perempuan sebagai sasaran pasif, melainkan sebagai perancang, pelaksana, dan penilai program. Pendekatan ini menuntut rancangan yang peka pada ritme hidup usia lanjut, hambatan mobilitas, kebutuhan kesehatan kronis, dan tanggung jawab pengasuhan cucu yang sering mereka pikul, sekaligus menghormati otonomi dan pilihan mereka terhadap aktivitas yang ingin dijalani.

Langkah pertama adalah menciptakan ruang aman dan bermakna untuk berpartisipasi. Di tingkat komunitas, posyandu lansia, posbindu penyakit tidak menular, majelis taklim, kelompok senam, koperasi, dan organisasi perempuan dapat dihidupkan kembali sebagai tempat perempuan lansia berkumpul, saling

belajar, dan mengambil keputusan. Ruang seperti ini akan efektif bila benar benar menampung suara mereka sejak tahap perencanaan. Fasilitator perlu sengaja mengundang lansia perempuan yang biasanya diam di rapat, menggunakan bahasa yang mudah, menyediakan kursi yang nyaman, penerangan yang baik, dan waktu pertemuan yang tidak bertabrakan dengan jam pengasuhan cucu atau kontrol kesehatan. Ketika forum menutup dengan ringkasan keputusan tertulis yang dibawa pulang, perempuan lansia dapat membahasnya di rumah dan kembali ke pertemuan berikutnya dengan pendapat yang lebih mantap. Dari forum inilah kepengurusan yang berisi lansia perempuan dapat dibentuk untuk memimpin kegiatan, mengelola anggaran kecil, dan menjadi penghubung resmi ke pemerintah desa atau kelurahan.

Pemberdayaan juga menyentuh peran kepemimpinan. Perempuan lansia sering dihormati sebagai penjaga nilai, tetapi jarang diberi kuasa operasional. Kuota kepemimpinan lansia perempuan dalam badan musyawarah desa, tim penggerak kesejahteraan keluarga, atau pengurus koperasi adalah sinyal kuat bahwa pengalaman dihargai setara dengan tenaga muda. Kuota saja tidak cukup tanpa dukungan praktis berupa pelatihan moderasi rapat, penyusunan notulen, komunikasi publik, serta pendampingan satu lawan satu pada rapat awal agar rasa percaya diri tumbuh. Ketika perempuan lansia memimpin dan terlihat memimpin, norma yang membatasi mereka di belakang layar perlahan bergeser.

Di ranah ekonomi, pemberdayaan berarti membuka jalan agar keterampilan lama tetap bernilai dan keterampilan baru dapat tumbuh tanpa membebani kesehatan. Banyak perempuan lansia memiliki keahlian kuliner, kerajinan, obat tradisional, atau jasa perawatan anak yang bisa diolah menjadi usaha mikro dengan arus kas sederhana. Dukungan yang dibutuhkan bukan sekadar pelatihan satu kali, melainkan rangkaian yang memadai, mulai dari pemetaan minat dan kemampuan, pendampingan menyusun rencana usaha yang realistis, bantuan perizinan dan label sederhana, akses bahan baku dengan harga wajar, sampai kanal pemasaran yang sesuai. Koperasi atau BUMDes dapat berperan sebagai agregator bahan dan sekaligus etalase penjualan agar lansia tidak harus berkeliling menjajakan produk.

Di kota, kolaborasi dengan kios, kantin komunitas, atau pasar daring lokal bisa menjadi pintu masuk. Akses pembiayaan mikro harus dilengkapi pendampingan literasi keuangan agar perempuan lansia tidak terjebak kredit konsumtif berbunga tinggi. Prinsip yang sama berlaku untuk ekonomi platform. Pelatihan digital perlu berjalan perlahan, berulang, dan didampingi, misalnya membuka akun jual beli, memotret produk dengan ponsel, membalas pesan pelanggan dengan template, dan memproses pembayaran tanpa mengorbankan keamanan data.

Program ekonomi yang sehat selalu berdampingan dengan perlindungan. Banyak penipuan menasar lansia melalui tautan palsu, hadiah undian, atau pinjaman cepat. Kelompok belajar keuangan di tingkat RT atau dusun dapat mengajarkan cara mengenali skema penipuan, membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun anggaran rumah tangga, dan menetapkan ambang aman untuk transaksi digital. Bank dan penyedia dompet digital bisa dilibatkan untuk membuat fitur verifikasi ganda yang sederhana dan menyediakan jalur layanan pelanggan bermitra dengan kader lokal, sehingga ketika terjadi kesalahan, pemulihan tidak memerlukan perjalanan jauh dan antrean panjang.

Pendidikan sepanjang hayat menjadi penguat utama pemberdayaan. Belajar di usia lanjut bukan sekadar mengejar ijazah, tetapi memelihara rasa ingin tahu dan kompetensi yang relevan. Materi bisa sangat beragam. Ada yang memilih kelas literasi kesehatan untuk memahami obat, label pangan, dan isyarat bahaya penyakit, sehingga kunjungan ke puskesmas terasa lebih terarah. Ada yang tertarik pada kelas literasi hukum untuk memahami waris, perjanjian jual beli, serta cara menyimpan dokumen penting. Ada pula yang membutuhkan literasi digital agar dapat berkomunikasi dengan anak cucu, mengakses bantuan sosial, atau menikmati konten yang memperkaya. Semua materi perlu dikemas dalam sesi pendek, repetitif, menggunakan contoh sehari-hari, dan memadukan teks besar, gambar, serta audio. Pendekatan antargenerasi sangat efektif, misalnya remaja mengajarkan ponsel kepada nenek dengan kurikulum yang disiapkan guru bimbingan konseling, sementara lansia mengajar memasak, berkebun, atau keterampilan tradisional

sebagai imbal balik. Pertukaran ini memperkuat harga diri dan mempererat ikatan sosial.

Pemberdayaan tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa banyak perempuan lansia adalah perawat tak dibayar. Mereka merawat pasangan yang sakit, cucu yang orang tuanya bekerja, atau kerabat yang disabilitas. Program yang peka akan menyediakan jeda perawatan, yaitu layanan pengganti sementara agar perawat dapat istirahat, ke pasar, atau hadir di kelas. Pelatihan merawat yang ringkas dan praktis membantu mengurangi cedera punggung, luka tekan, dan kelelahan mental. Dukungan psikososial berbentuk kelompok kecil yang difasilitasi pekerja sosial memberi ruang untuk berbagi strategi dan emosi tanpa rasa bersalah. Ketika peran perawatan diakui sebagai kerja, keluarga lebih mudah menerima pembagian tugas yang adil, misalnya anak laki-laki ikut menyumbang biaya atau waktu harian, bukan menyerahkan seluruh beban pada nenek.

Konektivitas sosial adalah urat nadi pemberdayaan. Rasa bermakna lahir dari partisipasi yang konsisten, bukan dari acara seremonial. Kalender kegiatan yang teratur seperti senam ringan, jalan pagi, membaca bersama, berkebun komunal, atau kelas keterampilan kecil menjaga ritme pertemuan dan peluang untuk saling jaga. Media lokal dan kanal digital komunitas dapat menonjolkan kisah praktik baik sehingga perempuan lansia melihat dirinya diwakili secara positif. Di beberapa tempat, forum konsultatif lansia perempuan di desa atau kelurahan dapat dibentuk untuk menyalurkan saran tentang perbaikan fasilitas umum yang ramah usia, misalnya kursi taman dengan sandaran, zebra cross yang jelas, dan lampu jalan yang memadai. Ketika saran mereka terlihat menjadi perubahan fisik, rasa memiliki terhadap lingkungan tumbuh dan partisipasi berikutnya menjadi lebih hidup.

Semua strategi tersebut memerlukan tata kelola yang tidak ruwet. Indikator yang dipakai sebaiknya mendekati kehidupan nyata, seperti berapa banyak lansia perempuan yang datang rutin ke kegiatan, seberapa sering mereka memimpin kelas, berapa usaha mikro yang bertahan setelah enam bulan, atau seberapa banyak yang menyelesaikan modul literasi digital dasar dan benar-benar menggunakannya. Dana

kecil yang fleksibel di tingkat komunitas mempercepat respons terhadap kebutuhan yang berubah. Mekanisme umpan balik sederhana, misalnya kartu penilaian yang diisi setelah sesi, memberi sinyal dini apakah materi terlalu cepat, jam tidak cocok, atau ruang tidak nyaman. Tidak kalah penting, seluruh program harus menjaga martabat dan otonomi. Pemberdayaan bukan memaksa perempuan lansia menjadi wiraswasta, pengguna gawai, atau aktivis. Pemberdayaan memberi pilihan, menghilangkan hambatan, dan mendukung keputusan yang mereka anggap paling berharga bagi hidupnya.

I. Peran Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah

Mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan lansia menuntut kerja bersama yang saling mengunci antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketiganya membentuk ekosistem yang menentukan apakah perempuan di usia lanjut diperlakukan sebagai subjek yang berdaya atau sekadar penerima belas kasih. Ekosistem ini bekerja baik ketika kebijakan publik memberi kepastian hak, komunitas menyediakan ruang aman dan kesempatan berpartisipasi, serta keluarga menegakkan penghormatan, pembagian peran yang adil, dan dukungan emosional yang konsisten.

Di tingkat keluarga, kesetaraan berawal dari pengakuan bahwa perempuan lansia berhak menentukan pilihan atas tubuh, waktu, tempat tinggal, dan asetnya sendiri. Percakapan yang jujur tentang kesehatan, keintiman, dan rencana keuangan perlu diletakkan pada posisi setara, bukan diarahkan sepihak oleh anak atau kerabat laki-laki. Keluarga yang sehat menyediakan ruang bagi perempuan lansia untuk menyampaikan keinginannya, misalnya jadwal kontrol, jenis bantuan yang dibutuhkan di rumah, atau keputusan untuk tetap berkegiatan di luar. Pengaturan peran perawatan juga perlu ditata ulang. Banyak rumah tangga menggantungkan pengasuhan cucu dan perawatan anggota keluarga yang sakit kepada nenek sebagai sesuatu yang otomatis. Prinsip yang lebih adil adalah membagi tanggung jawab pengasuhan dan biaya perawatan lintas anggota keluarga, memberi jeda

istirahat terjadwal bagi perawat utama, serta mengakui kebutuhan perempuan lansia untuk merawat diri tanpa rasa bersalah. Dukungan kecil yang tampak sederhana, seperti mengantar ke fasilitas kesehatan, menata ulang kamar agar aman dari risiko jatuh, atau mendampingi proses klaim jaminan sosial, berdampak besar pada rasa aman dan otonomi.

Masyarakat berperan sebagai jembatan antara ruang privat dan kebijakan. Organisasi warga, kelompok pengajian, posyandu lansia, koperasi, dan sanggar seni dapat menjadi tempat perempuan lansia membangun jejaring, belajar, dan memimpin. Partisipasi akan tumbuh jika forum benar benar ramah usia. Ruang pertemuan perlu terang dan mudah diakses, kursi nyaman, tulisan materi berukuran besar, serta jadwal yang tidak bertabrakan dengan jam pengasuhan atau kontrol rutin. Fasilitator perlu mengundang perempuan lansia yang cenderung diam untuk berbicara dan menutup pertemuan dengan ringkasan yang bisa dibawa pulang, sehingga keputusan forum tidak hanya milik mereka yang paling vokal. Komunitas juga dapat mengubah norma dengan menghadirkan representasi positif lansia perempuan pada acara publik dan media lokal. Ketika perempuan lansia tampil sebagai narasumber, instruktur keterampilan, atau pemimpin panitia, pesan kepada warga menjadi jelas bahwa usia tidak menghapus suara dan nilai.

Kegiatan ekonomi produktif yang berbasis komunitas memperkuat kemandirian. Banyak perempuan lansia memiliki keterampilan kuliner, kerajinan, pengobatan tradisional, atau jasa perawatan anak yang dapat diolah menjadi usaha kecil yang realistis. Koperasi dan badan usaha milik desa dapat membantu pengadaan bahan, standarisasi kemasan, dan pemasaran tanpa menuntut mobilitas yang melelahkan. Pelatihan keuangan sederhana dan perlindungan dari pinjaman berbunga tinggi perlu berjalan beriringan agar pemberdayaan tidak berubah menjadi jerat hutang. Di wilayah perkotaan, pasar daring tingkat lokal dan bazar komunitas menjadi kanal efektif jika didampingi literasi digital yang pelan, berulang, dan aman. Semua dukungan ini sebaiknya mematuhi ritme kesehatan lansia,

memberi fleksibilitas jam kerja, dan menempatkan target pada keberlanjutan arus kas, bukan pada pertumbuhan yang menyedot energi.

Komunitas juga berfungsi sebagai penyangga bagi kesehatan mental dan pencegahan kekerasan. Kelompok sebaya yang difasilitasi pekerja sosial atau kader terlatih memberi ruang aman untuk berbagi strategi menghadapi duka, kesepian, atau tekanan peran. Kanal pengaduan yang mudah diakses dan dilindungi kerahasiaannya penting untuk menangani kekerasan fisik, psikologis, maupun ekonomi terhadap perempuan lansia. Jaringan relawan yang peka dapat melakukan kunjungan ramah, membantu administrasi, dan memastikan bantuan sosial tidak berhenti di meja kelurahan. Dalam situasi bencana dan guncangan ekonomi, struktur komunitas inilah yang sering pertama kali menjangkau perempuan lansia, sehingga rencana tanggap darurat di tingkat desa sebaiknya menempatkan kebutuhan mereka secara eksplisit, termasuk akses transportasi aman, daftar kontak darurat, dan titik layanan yang mudah dicapai.

Pada sisi pemerintah, pilar pertama adalah kebijakan yang menempatkan lansia perempuan sebagai subjek dalam seluruh siklus kebijakan. Pengarusutamaan gender perlu dipadukan dengan lensa penuaan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. Data yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, disabilitas, dan lokasi menjadi syarat agar ketimpangan terlihat dan tidak tersamar dalam angka rata-rata. Sistem perlindungan sosial harus menjangkau pekerja informal yang mayoritas perempuan melalui pensiun sosial minimum, iuran ringan yang disubsidi untuk tabungan hari tua, dan manfaat turut hidup bagi janda. Hak atas aset dapat diperkuat dengan kemudahan sertifikasi bersama, layanan balik nama yang sederhana, dan bantuan hukum proaktif pada kasus waris. Pengaturan ini bukan hanya melindungi rumah dan lahan, tetapi menegakkan martabat melalui kontrol terhadap keputusan sehari-hari.

Di sektor kesehatan, standar layanan geriatri yang peka gender perlu menjadi prosedur baku di layanan primer. Penilaian menyeluruh yang mencakup fungsi, kognisi, suasana hati, nutrisi, risiko jatuh, serta telaah obat sebaiknya dilakukan pada

kunjungan rutin, bukan menunggu rujukan ke rumah sakit. Kesehatan reproduksi lanjut usia harus dinormalisasi dalam konseling, termasuk penanganan nyeri saat berhubungan, inkontinensia, prolaps organ panggul, serta edukasi mengenai pencegahan infeksi menular seksual tanpa nada menghakimi. Di kesehatan mental, skrining singkat untuk depresi dan kecemasan perlu disertai jalur rujukan yang jelas dan dukungan bagi keluarga perawat demensia. Telekesehatan dapat memperluas akses, terutama di wilayah terpencil, jika disertai antarmuka sederhana, opsi audio, dan perlindungan kerahasiaan agar perempuan dapat berkonsultasi tanpa tekanan dari pendamping yang dominan.

Transportasi, perumahan, dan lingkungan binaan yang ramah usia adalah wujud konkret kebijakan lintas sektor. Trotoar yang rata, lampu jalan yang memadai, kursi tunggu dengan sandaran di fasilitas umum, serta transportasi dengan prioritas lansia membuat mobilitas menjadi mungkin sehingga partisipasi sosial dan akses layanan meningkat. Program perbaikan rumah sederhana yang berfokus pada pengurangan risiko jatuh, seperti pegangan di kamar mandi dan penerangan di tangga, sering lebih efektif meningkatkan kualitas hidup dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif. Semua intervensi sebaiknya mengikutsertakan perempuan lansia dalam tahap desain melalui uji coba pengguna agar solusi tidak berhenti pada gambar teknis.

Koordinasi lintas institusi menentukan apakah kebijakan berjalan sebagai sistem. Pemerintah daerah dapat membentuk sekretariat penuaan sehat yang melibatkan dinas sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta organisasi masyarakat sipil dan kelompok lansia. Forum ini menyepakati target yang bermakna, misalnya penurunan kesepian yang diukur dengan instrumen sederhana, peningkatan cakupan pensiun sosial bagi perempuan, atau bertambahnya kepengurusan lansia perempuan di lembaga warga. Mekanisme akuntabilitas yang ramah publik, seperti papan kemajuan di puskesmas dan situs resmi berbahasa sederhana, memberi sinyal bahwa suara warga didengar. Anggaran

responsif gender dan usia memastikan program yang efektif tetap mendapat bahan bakar fiskal, bukan hanya dukungan retorik.

Sektor swasta dan filantropi dapat menjadi mitra yang mempercepat kemajuan. Perusahaan dapat merancang kebijakan kerja ramah usia, membuka peluang paruh waktu yang aman bagi lansia perempuan, dan berinvestasi pada infrastruktur komunitas. Bank dan penyedia layanan keuangan dapat menyiapkan produk yang melindungi dari penipuan, menyediakan verifikasi ganda yang mudah, serta layanan pelanggan yang bekerja sama dengan kader lokal. Filantropi dapat mengisi celah inovasi, dari laboratorium pendidikan digital untuk lansia, klinik hukum keliling, hingga platform pemasaran hasil karya lansia perempuan. Kemitraan perlu diikat dengan prinsip akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan keterlibatan langsung pengguna.

Seluruh dukungan lintas sektor tadi pada akhirnya diukur dari perubahan yang dirasakan sehari-hari oleh perempuan lansia. Apakah mereka lebih leluasa memutuskan jadwal dan cara berobat. Apakah suara mereka dihitung dalam musyawarah keluarga dan forum warga. Apakah pendapatan kecil dari usaha rumahan stabil tanpa menimbulkan kelelahan. Apakah mereka dapat berbicara tentang keintiman dan kesehatan mental tanpa malu dan tanpa ditertawakan. Dan apakah bantuan sosial datang tepat waktu tanpa prosedur yang melelahkan. Ketika keluarga menegakkan penghormatan dan berbagi peran, masyarakat membuka ruang aman dan kesempatan memimpin, serta pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak dan konsisten dijalankan, kesetaraan gender pada perempuan lansia bergerak dari wacana menuju kenyataan. Hasilnya bukan hanya lansia yang lebih sehat dan mandiri, melainkan komunitas yang lebih hangat dan negara yang lebih adil bagi setiap tahap kehidupan.

J. Peluang Inovasi dan Teknologi untuk Kesetaraan Gender Lansia

Teknologi membuka jalan pintas yang selama ini tertutup oleh jarak, waktu, dan norma yang membatasi peran perempuan di usia lanjut. Ketika sebuah ponsel

sederhana dapat menjadi pintu ke layanan kesehatan, ruang belajar, dan pasar, maka kesetaraan gender tidak lagi bergantung semata pada keberanian menembus batas ruang fisik. Kuncinya adalah menjadikan inovasi sebagai alat yang menambah kendali perempuan lansia atas keputusan sehari-hari, bukan sekadar menambah fitur yang rumit. Inovasi yang tepat akan memungkinkan mereka memilih kapan berkonsultasi dengan dokter, bagaimana berhubungan dengan keluarga dan komunitas, cara mengelola uang sendiri, serta medium yang nyaman untuk menyuarakan pendapat di forum warga.

Telemedicine merupakan contoh paling nyata bagaimana teknologi menyatukan layanan kesehatan dan kehidupan rumah tangga yang sibuk dengan pengasuhan cucu atau kerja perawatan lain. Konsultasi video atau telepon yang terjadwal pada jam yang sesuai ritme lansia mengurangi ongkos transportasi, menekan kelelahan akibat antre, dan memperkecil risiko menunda berobat. Agar benar benar inklusif, telemedicine perlu menghadirkan antarmuka ringkas dengan tombol besar, pilihan audio bagi yang kesulitan membaca, serta panduan langkah demi langkah yang muncul tepat saat dibutuhkan, misalnya tips menstabilkan kamera atau cara mengirim foto obat. Fitur penerjemah yang bekerja di latar dapat membantu perempuan yang lebih fasih berbahasa daerah, sementara opsi konferensi tiga pihak memungkinkan pendamping turut hadir tanpa mengambil alih pembicaraan antara pasien dan tenaga kesehatan. Konsultasi jarak jauh akan semakin bermanfaat jika terhubung dengan catatan kesehatan yang dapat dilihat kembali, pengingat minum obat, dan rujukan yang langsung mengeluarkan jadwal kunjungan atau tes laboratorium terdekat.

Aplikasi kesehatan yang dirancang untuk usia lanjut dapat menjadi pendamping harian yang praktis. Jurnal gejala sederhana membantu mengenali pola nyeri sendi, gangguan tidur, atau gejala urogenital yang sering ditahan karena malu. Pengingat minum obat yang menyesuaikan kebiasaan makan dan waktu ibadah membantu kepatuhan tanpa terasa menggurui. Modul latihan ringan dengan video berdurasi singkat menjaga kekuatan otot dan keseimbangan, sementara

panduan merapikan rumah agar aman dari jatuh menghadirkan pencegahan yang terasa di ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Pada isu yang kerap dianggap tabu, seperti nyeri saat berhubungan atau kekeringan pascamenopause, aplikasi dapat menyediakan ruang privat untuk belajar bahasa yang tepat sebelum berdiskusi dengan pasangan atau dokter. Semua ini akan bekerja baik jika data yang dikumpulkan minimal, persetujuan jelas dan dapat dicabut, serta riwayat dapat dihapus oleh pengguna kapan saja tanpa meminta bantuan anggota keluarga.

Konektivitas sosial adalah kebutuhan yang tidak kalah penting dibanding obat dan kontrol rutin. Aplikasi perpesanan dan jejaring komunitas memberi ruang bagi perempuan lansia untuk terhubung dengan kelompok senam, pengajian, koperasi, hingga forum warga. Kelompok sebaya di ruang digital membantu menormalkan pengalaman yang selama ini disembunyikan, seperti cara menghadapi kesepian setelah anak merantau, tips bernegosiasi pembagian tugas pengasuhan cucu, atau rekomendasi dokter yang komunikatif. Moderasi yang peka budaya dan umur menjaga percakapan tetap aman dari candaan yang merendahkan atau tautan penipuan. Untuk mereka yang baru belajar, model belajar berpasangan antara cucu dan nenek sering lebih efektif daripada kelas formal karena menyatukan kasih, kesabaran, dan praktik langsung. Di daerah yang koneksinya terbatas, komunitas dapat menggabungkan pusat internet desa, radio komunitas, dan pesan singkat berjadwal agar informasi kunci tetap sampai dengan cara yang terjangkau.

Teknologi juga membuka peluang ekonomi yang konkret bagi perempuan lansia. Pasar daring tingkat lokal, aplikasi pemesanan makanan rumahan, serta katalog kerajinan komunitas memberi kanal baru bagi keterampilan kuliner, menjahit, anyaman, atau tanaman obat. Pendampingan yang baik dimulai dari pemetaan minat dan kapasitas, lalu membantu menata foto produk, menulis deskripsi yang jujur, menetapkan harga yang masuk akal, dan mengatur ritme produksi agar tidak menguras tenaga. Pembayaran nontunai akan terasa aman jika penyedia layanan menghadirkan verifikasi ganda yang mudah, batas transaksi harian yang bisa disetel, serta jalur bantuan yang dapat dihubungi melalui telepon

biasa. Bank dan dompet digital dapat menambahkan fitur pencegah penipuan yang tampil jelas, seperti peringatan ketika menerima pesan dengan ajakan mengisi data pribadi atau tautan mencurigakan. Dengan cara ini, teknologi finansial tidak sekadar menjadi mekanisme pencairan bantuan sosial, tetapi juga perisai dari kekerasan ekonomi yang kerap menyasar perempuan tua.

Pendidikan sepanjang hayat menemukan sekutu kuat dalam media online. Kursus mikro tentang literasi kesehatan, hak waris, atau pengelolaan usaha kecil dapat dipecah menjadi sesi pendek yang ditonton ulang kapan saja. Video dengan teks besar dan suara jernih, kuis ringan yang memicu ingatan, serta tugas kecil yang langsung dipraktikkan di rumah membuat pembelajaran terasa menyenangkan. Banyak perempuan lansia menyukai pola belajar yang berdampingan dengan aktivitas harian, misalnya menonton panduan membuat kemasan sambil memasak, atau mengikuti latihan pernapasan sebelum tidur. Platform pembelajaran yang baik memberi penghargaan atas konsistensi, bukan kecepatan, dan menyediakan dukungan teknis yang tidak membuat malu saat bertanya. Model pembelajaran antargenerasi patut didorong, karena ketika lansia berbagi kearifan tentang pengasuhan, resep tradisional, atau keterampilan berkebun kepada generasi muda, harga diri tumbuh seiring transfer pengetahuan digital dari anak dan cucu.

Teknologi bantu dan perangkat dapat menambah rasa aman tanpa menghilangkan kendali. Jam tangan dengan sensor jatuh yang mengirim peringatan kepada kontak tepercaya memberi ketenangan pada perempuan yang tinggal sendiri, asalkan izin diberikan secara sadar dan dapat diubah kapan saja. Sensor sederhana di rumah untuk lampu otomatis, peringatan kebocoran gas, atau pengingat pintu belum terkunci menyelesaikan masalah praktis yang bisa berujung bahaya. Di wilayah pedesaan, layanan panggilan darurat komunitas yang diintegrasikan dengan puskesmas dan perangkat sederhana sering lebih berguna daripada solusi mahal yang bergantung pada internet cepat. Prinsip utamanya tetap sama, yaitu teknologi memudahkan, bukan mengendalikan, dan keputusan akhir berada di tangan pemakai.

Tidak ada inovasi yang netral. Semua harus diuji dengan lensa gender dan usia. Algoritme rekomendasi yang menampilkan konten menyesatkan tentang obat ajaib mudah menjerat perempuan lansia yang mencari harapan cepat. Desain antarmuka yang ramai menimbulkan kelelahan visual dan kebingungan. Persetujuan data yang ditulis dengan bahasa rumit membuat pengguna memberi akses lebih dari yang dimaksud. Penyedia layanan berkewajiban menyediakan penjelasan singkat yang jernih, memungkinkan pemakaian anonim pada tahap belajar, serta memisahkan akses antara pengguna dan anggota keluarga yang mendampingi, agar privasi isu sensitif tetap terlindungi. Di sisi keamanan, platform perlu menyediakan tombol lapor yang mudah, pemblokiran satu ketukan, serta tim respons penipuan yang benar benar bisa dihubungi, bukan sekadar formulir yang tidak jelas tindak lanjutnya.

Transformasi digital yang adil bagi perempuan lansia membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan. Subsidi perangkat sederhana, paket data ramah lansia, dan pusat layanan tatap muka di tingkat desa atau kelurahan akan menutup jurang awal. Pengadaan layanan publik perlu mensyaratkan antarmuka ramah usia dan uji coba bersama pengguna lansia perempuan sebelum diluncurkan luas. Program pemerintah yang mengandalkan aplikasi wajib menyediakan alternatif non digital yang bermartabat agar hak layanan tidak bergantung pada kepemilikan gawai. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan pelaku usaha kecil dapat memperkaya konten lokal yang relevan, dari tutorial bahasa daerah hingga katalog layanan kesehatan terdekat yang benar benar diperbarui.

Ujung dari semua peluang ini adalah bertambahnya pilihan yang realistis bagi perempuan lansia. Mereka dapat memilih konsultasi kesehatan dari rumah pada hari yang padat pengasuhan, mengelola usaha rumahan dengan ritme yang menyehatkan, mengikuti kelas singkat sesuai minat, dan bersuara di forum warga tanpa harus memaksa tubuh melampaui batas. Mereka terlindungi dari penipuan karena peka terhadap tanda bahaya, dan mampu menjaga privasi karena teknologi memberi kendali, bukan meminjamnya. Ketika inovasi dirancang dengan hati hati,

berangkat dari pengalaman nyata, serta disokong kebijakan yang berpihak, teknologi bukan sekadar alat baru, melainkan jembatan menuju kesetaraan yang dihidupi, di usia berapa pun.

K. Simpulan

Bab ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender pada perempuan lansia bukan isu tepi, melainkan prasyarat penuaan penduduk yang adil. Perempuan memasuki usia lanjut dengan “warisan” ketimpangan sepanjang hidup: jeda karier karena pengasuhan, kerja domestik yang tidak dibayar, upah lebih rendah, akses pendidikan dan aset yang timpang, serta norma yang menyingkirkan suara mereka dari pengambilan keputusan. Ketika usia bertambah, akumulasi tersebut berjumpa dengan penurunan fungsi, biaya kesehatan yang naik, jejaring sosial yang menyusut, dan arsitektur layanan yang belum ramah usia. Hasilnya adalah kerentanan ganda yang tidak pernah akan selesai bila kesetaraan dibaca semata sebagai urusan generasi muda.

Kesetaraan di usia lanjut menuntut pergeseran dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif. Perlakuan yang sama tidak cukup bila medan berpijak tidak setara. Perempuan lansia membutuhkan afirmasi yang realistis: jaminan sosial minimum bagi pekerja informal, kredit pengasuhan dalam rumus pensiun, layanan geriatri yang wajib memasukkan penilaian fungsional dan kesehatan mental, kemudahan balik nama aset bagi janda, serta kanal keadilan yang tidak melelahkan. Semua itu harus berdiri di atas data terpilah menurut jenis kelamin, umur, disabilitas, dan lokasi, agar ketimpangan tidak lagi bersembunyi di balik angka rata rata.

Martabat menjadi poros dari seluruh agenda. Di rumah, martabat terwujud sebagai otonomi atas tubuh, waktu, dan aset, serta pembagian peran perawatan yang adil. Di komunitas, martabat hadir ketika perempuan lansia dilihat sebagai warga yang berdaya, diundang berbicara, memimpin kegiatan, dan menjadi rujukan keputusan, bukan sekadar “penerima bantuan.” Di layanan kesehatan, martabat berarti keluhan nyeri, keintiman, depresi, dan demensia didengar dengan serius,

dijelaskan dengan bahasa yang dipahami, dan ditautkan dengan tindak lanjut yang masuk akal. Di ranah hukum, martabat dijaga melalui perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi, serta kepastian hak atas tempat tinggal dan waris.

Stigma berbasis usia yang berkelindan dengan bias gender adalah penghalang kultural terbesar. Ia bekerja melalui candaan, sapaan, tata ruang, dan prosedur yang tanpa sadar mengerdilkan kapasitas perempuan lansia. Bab ini menegaskan bahwa perubahan norma adalah kerja lintas ruang: keluarga yang mengubah cara bercakap, media yang menampilkan representasi positif, pemuka agama yang memaknai penghormatan sebagai pemberian kuasa praktis, serta tenaga layanan yang berhenti menginfantilisasi pasien lansia. Ketika bahasa berubah, perilaku ikut bergeser, dan ruang gerak perempuan melebar.

Pemberdayaan adalah jalan tengah antara perlindungan dan partisipasi. Program yang berhasil tidak memaksa lansia perempuan menyesuaikan diri dengan tempo orang muda, tetapi menyesuaikan tempo program dengan ritme hidup mereka. Ia menciptakan ruang aman untuk belajar dan memimpin, menghubungkan keterampilan lama dengan pasar baru, menyediakan jeda bagi perawat keluarga, dan menghidupkan kembali dukungan sebaya. Pendidikan sepanjang hayat, literasi keuangan dan digital yang pelan dan berulang, serta pendampingan usaha mikro yang sabar membuat otonomi ekonomi tumbuh tanpa mengorbankan kesehatan.

Inovasi teknologi menjadi pengungkit bila dirancang dengan lensa gender dan usia. Telemedicine yang sederhana, aplikasi kesehatan dengan izin data yang jelas dan dapat dicabut, komunitas daring yang dimoderasi, fitur keamanan finansial yang mudah dipakai, serta perangkat bantu yang meningkatkan kemandirian memperpendek jarak layanan, mengurangi biaya, dan memperluas pilihan. Namun teknologi bukan tujuan. Ia hanyalah jembatan yang bernilai sejauh memberi kendali kepada pengguna, menjaga privasi, dan selalu menyediakan alternatif non digital yang bermartabat.

Kesetaraan lintas usia tidak lahir dari satu sektor. Keluarga mengawal penghormatan dan pembagian peran; masyarakat membuka ruang partisipasi dan

perlindungan sosial berbasis warga; pemerintah menjamin hak melalui kebijakan, anggaran, standar layanan, serta akuntabilitas yang dapat diperiksa publik. Sinergi ketiganya diukur bukan dari banyaknya program, tetapi dari perubahan yang dirasakan: tidur yang lebih tenang karena nyeri dan cemas berkurang, akses berobat yang mudah tanpa antri melelahkan, pendapatan kecil yang stabil dari usaha rumahan, keputusan keluarga yang benar benar didiskusikan, dan hilangnya rasa malu ketika membicarakan isu yang dulu tabu.

L. Referensi

- Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (2010). General recommendation No. 27 on older women and protection of their human rights (CEDAW/C/GC/27). United Nations.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (1995). General Comment No. 6: The economic, social and cultural rights of older persons (E/1996/22).
- HelpAge International. (2015). Global AgeWatch Index 2015: Insight report. HelpAge International.
- International Labour Organization. (2021). World social protection report 2020–22: Social protection at the crossroads—In pursuit of a better future. ILO.
- OECD. (2017). Preventing ageing unequally. OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Lembaran Negara RI.

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- UNFPA, & HelpAge International. (2012). Ageing in the twenty-first century: A celebration and a challenge. United Nations Population Fund.
- United Nations. (2002). Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing. United Nations.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). United Nations.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2022). World population ageing 2022. UN DESA.
- UN Women. (2019). Progress of the world's women 2019–2020: Families in a changing world. UN Women.

World Bank. (2016). Live long and prosper: Aging in East Asia and Pacific. World Bank.

World Health Organization. (2007). Global age-friendly cities: A guide. WHO.

World Health Organization. (2015). World report on ageing and health. WHO.

World Health Organization. (2019). Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care. WHO.

World Health Organization. (2020). Decade of healthy ageing 2020–2030. WHO.

World Health Organization. (2021). Global report on ageism. WHO.

World Health Organization. (2007). Women, ageing and health: A framework for action—Focus on gender. WHO.

M. Glosarium

Ageisme (ageism): Sikap, prasangka, atau praktik diskriminatif berdasarkan usia yang merendahkan atau membatasi peran dan hak lansia, sering berkelindan dengan bias gender pada perempuan lanjut usia.

Akomodasi yang Layak: Penyesuaian wajar pada layanan, sarana, atau prosedur (misalnya kursi ber sandaran, pencahayaan cukup, toilet aksesibel) agar lansia termasuk penyandang disabilitas dapat mengakses hak dan layanan setara.

Akses Keadilan: Kemampuan lansia perempuan menggunakan mekanisme hukum dan administratif (bantuan hukum, pengadilan, pengaduan layanan) secara aman, terjangkau, dan tanpa diskriminasi.

Akses Layanan Kesehatan yang Bermakna: Bukan sekadar keberadaan fasilitas, melainkan kemudahan menjangkau, menerima, memanfaatkan, dan merasakan manfaat layanan sesuai kebutuhan dan preferensi lansia perempuan.

Aset Atas Nama Sendiri: Kepemilikan formal (rumah, tanah, rekening) yang terdaftar atas nama perempuan, meningkatkan kendali atas keputusan dan perlindungan dari risiko terusir setelah menjadi janda/bercerai.

Candaan/Infantilisasi: Cara berbahasa atau memperlakukan lansia seperti anak kecil (misal memotong penjelasan medis, berbicara kepada pendamping alih-alih pasien), yang mengikis otonomi dan martabat.

Celah Pensiun (Pension Gap): Kesenjangan hak/benefit pensiun yang dialami perempuan akibat upah lebih rendah, jeda karier pengasuhan, dan masa iur pendek memperbesar risiko kemiskinan di usia tua.

Dekade Penuaan Sehat: Agenda global yang mendorong lingkungan ramah usia, penanganan ageisme, layanan terintegrasi berpusat pada individu, dan sistem perawatan jangka panjang yang dapat diandalkan.

Demensia: Sindrom penurunan kognitif progresif yang memengaruhi memori, penilaian, dan fungsi harian; membutuhkan penilaian, dukungan keluarga perawat, serta intervensi nonfarmakologis berkelanjutan.

Depresi Lanjut Usia: Gangguan suasana hati pada lansia, sering tersamarkan sebagai “wajar karena tua”. Ditandai kehilangan minat, lelah, gangguan tidur; perlu skrining dan terapi yang peka usia dan gender.

Equity (Keadilan): Pemberian dukungan berbeda sesuai kebutuhan agar hasil menjadi setara. Berbeda dari *equality* yang memaknai perlakuan sama apa adanya.

Feminisasi Penuaan: Proporsi lansia yang lebih banyak perempuan, dengan konsekuensi kebijakan karena banyak perempuan menua bersama akumulasi ketimpangan sepanjang hidup.

Fragilitas: Keadaan kerentanan fisiologis (kelemahan, berat badan turun, mudah lelah) dengan risiko jatuh, rawat inap, dan kemandirian menurun; memerlukan pendekatan multidisiplin.

Hak Waris dan Balik Nama: Pengakuan hukum atas hak kepemilikan perempuan terhadap harta bersama/warisan serta prosedur administrasi sederhana untuk menjamin keamanan tempat tinggal dan aset.

Inkontinensia Urin: Kesulitan menahan kencing pada lansia perempuan; dapat ditangani dengan edukasi, latihan dasar panggul, terapi lokal, alat bantu, atau rujukan lanjut.

Jaminan Sosial Minimum: Skema benefit non-iuran (pensiun sosial, bantuan tunai) bagi lansia tanpa perlindungan pensiun untuk mencegah kemiskinan ekstrem di usia tua.

Kader/Posyandu Lansia: Jejaring komunitas yang menyelenggarakan pemantauan kesehatan dasar, edukasi, dan rujukan untuk lansia—efektif bila ramah gender, bahasa sederhana, dan konsisten.

Kebijakan Ramah Usia: Aturan dan program lintas sektor (kesehatan, transportasi, perumahan, sosial) yang mengakui kebutuhan lansia, meningkatkan partisipasi, dan melindungi martabat.

Kekerasan Ekonomi pada Lansia: Pengambilalihan aset, manipulasi keuangan, penipuan, atau pembatasan akses uang oleh kerabat/pihak lain yang merugikan lansia perempuan.

Kelelahan Perawat (Caregiver Burnout): Tekanan fisik-emosional pada lansia perempuan yang merawat pasangan/keluarga; memerlukan jeda perawatan, dukungan psikososial, dan pelatihan merawat.

Kesetaraan Gender Substantif: Kondisi saat perempuan lansia benar-benar menikmati hasil pembangunan setara melalui penghapusan hambatan dan dukungan afirmatif, bukan sekadar kesetaraan formal di atas kertas.

Kesehatan Reproduksi Lanjut Usia: Layanan bermartabat terkait sindrom urogenital pascamenopause (kekeringan, nyeri saat berhubungan), prolaps, dan kesehatan seksual—sering terabaikan karena stigma.

Kota/Komunitas Ramah Lansia: Lingkungan yang menyediakan trotoar rata, kursi istirahat, pencahayaan baik, transportasi prioritas lansia, dan fasilitas publik aksesibel.

Layanan Geriatri Terintegrasi: Penilaian menyeluruh (fungsi, kognisi, suasana hati, nutrisi, risiko jatuh, telaah obat) dan rencana tindak lanjut lintas profesi yang berpusat pada lansia.

Literasi Digital untuk Lansia: Kecakapan menggunakan perangkat/aplikasi secara aman (komunikasi, akses layanan, transaksi), dengan pembelajaran pelan, berulang, dan berbasis praktik.

Literasi Keuangan Lansia: Kemampuan mengatur anggaran, memahami produk keuangan, menghindari utang predator/penipuan, dan mengelola pendapatan mikro secara stabil.

Martabat (Dignity): Penghormatan terhadap nilai diri lansia perempuan melalui otonomi keputusan, bahasa yang memuliakan, privasi, dan akses layanan yang adil.

Otonomi Pasien: Hak lansia perempuan menentukan pilihan atas tubuh, waktu, layanan kesehatan, dan aset setelah menerima informasi yang memadai (persetujuan yang diinformasikan).

Partisipasi Bermakna: Keterlibatan nyata lansia perempuan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program/anggaran—bukan kehadiran simbolik.

Pascamenopause/Sindrom Urogenital: Perubahan jaringan urogenital setelah menopause (kekeringan, nyeri, urgensi berkemih) yang memengaruhi kenyamanan dan relasi intim.

Pengambilan Keputusan yang Didukung: Model dukungan bagi lansia untuk memahami informasi, menimbang pilihan, dan memutuskan sendiri—alternatif etis terhadap perwalian yang membatasi.

Pengarusutamaan Gender (PUG): Strategi memasukkan perspektif gender di seluruh siklus kebijakan—dengan data terpilah, analisis kesenjangan, desain responsif gender—termasuk untuk isu lansia.

Penilaian Geriatri Komprehensif (PGK/CGA): Kerangka klinis multidimensi untuk menyusun rencana perawatan individual lansia; inti layanan geriatri berkualitas.

Pensiun Sosial Non-Iuran: Manfaat tunai periodik bagi lansia tanpa riwayat iuran—jangkar minimum untuk melindungi kesejahteraan dasar.

Perawatan Jangka Panjang: Dukungan layanan berkelanjutan (rumah, komunitas, fasilitas) untuk lansia dengan keterbatasan fungsi, mencakup aspek medis dan sosial.

Perawatan Jeda (Respite Care): Layanan pengganti sementara agar perawat keluarga dapat beristirahat—mengurangi risiko kelelahan dan meningkatkan kualitas perawatan.

Polypharmacy: Penggunaan banyak obat secara bersamaan—meningkatkan risiko interaksi/efek samping pada lansia; perlu telaah obat berkala.

Portabilitas Manfaat: Kemampuan manfaat jaminan sosial/pensiun “dibawa” saat pindah kerja/lokasi, penting bagi perempuan dengan riwayat kerja tidak linier.

Posbindu PTM: Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular di komunitas untuk skrining/edukasi; efektif bila inklusif dan ramah lansia perempuan.

Ruang Aman: Lingkungan fisik/psikologis yang melindungi privasi, bebas stigma, dan memungkinkan lansia perempuan berbicara serta mengambil keputusan tanpa tekanan.

Sensor Jatuh/Perangkat Bantu: Teknologi sederhana (jam tangan dengan deteksi jatuh, pegangan kamar mandi, lampu otomatis) yang meningkatkan keselamatan dan kemandirian.

Sarkopenia: Penurunan massa dan kekuatan otot terkait usia—meningkatkan risiko jatuh dan ketergantungan; dapat ditangani dengan latihan kekuatan dan nutrisi adekuat.

Skema Pembiayaan Mikro Ramah Lansia: Kredit modal kecil dengan pendampingan dan perlindungan dari praktik predator, disesuaikan ritme kesehatan/produksi lansia perempuan.

Stigma Janda pada Lansia: Penilaian moral/larangan budaya yang membatasi pilihan hidup janda lansia (termasuk hak menikah kembali, hak tinggal, atau hak aset).

Telemedicine Ramah Lansia: Konsultasi jarak jauh dengan antarmuka sederhana, opsi audio, pelibatan pendamping sesuai persetujuan pasien, serta perlindungan privasi.

Tenaga Perawat Keluarga: Anggota keluarga—sering perempuan lansia—yang merawat pasangan/cucu/kerabat; membutuhkan pelatihan, jeda, dan dukungan finansial/psikososial.

Verifikasi Ganda (Keamanan Finansial Digital): Lapisan pengamanan transaksi (OTP, PIN, batas harian) untuk mencegah penipuan yang menyasar lansia perempuan.

Women–Age Intersection (Interseksionalitas Usia–Gender): Persilangan ketidaksetaraan karena menjadi perempuan *dan* lansia—menciptakan hambatan ganda di kesehatan, ekonomi, dan hukum.

Zona Ramah Usia di Pelayanan Publik: Penataan area layanan dengan antrean prioritas, kursi nyaman, huruf besar pada formulir, dan petugas terlatih agar akses benar-benar inklusif.

PROFIL PENULIS



Bdn.Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb, lahir di Tanete pada tanggal 16 Mei 1998. Penulis menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi D IV Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Makassar dan berhasil meraih gelar Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb) pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Kebidanan (M.Keb) di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2025, Penulis melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan profesi bidan (Bdn) di Politeknik Tiara Bunda. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap di

Akademi Kebidanan Murung Raya dengan mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan (KDPK), Etikolegal dalam Kebidanan, Asuhan Kehamilan, Asuhan Persalinan, dan Asuhan Nifas. Selain kegiatan pendidikan, penulis juga aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain menulis dan menyusun buku ajar, melakukan penelitian serta publikasi ilmiah, menjadi pemateri dalam seminar, serta mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: meidayanarefisiliyani@akbidmurungraya.ac.id

Motto: "Lifelong learning is the key to future success"



Nama Bd. Muliana, S. Tr. Keb., M.K.M Lahir di Aceh Besar, 08 September 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Diploma Kebidanan Universitas Ubudiyah pada Tahun 2011, melanjutkan D4 pada Program Studi Kebidanan Universitas Ubudiyah pada Tahun 2015, melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Aceh dan lulus tahun pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan Profesi Bidan di Stikes Muhammadiyah Aceh lulus Pada Tahun 2023. Saat ini penulis bekerja

sebagai Dosen Tetap Non Struktural di Universitas Bina Bangsa Getsempena dari bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Bangsa Getsempena mengampu mata kuliah Evidence Based Dalam Praktik Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Antropologi dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kehamilan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan lain-lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maulianaa.9393@gmail.com.

Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Ngatemi, S.Si.T., MKM. Lahir di Yogyakarta, tanggal 5 April 1967. Tinggal di Jl. Pinang V Gg.H. Arif No. 48 RT 009/009 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Pekerjaan sebagai ASN dengan pangkat/golongan Pembina/IV B. Jabatan sebagai Dosen (Lektor Kepala) Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Pengalaman kerja, pernah bekerja di Puskesmas Semin 1986, kemudian tahun 1987 diangkat menjadi PNS sebagai Guru SPRG Yogyakarta sejak tahun 1987 sampai tahun 1997. Kemudian mutasi kerja ke Poltekkes Jakarta I, sebagai dosen dengan mengampu mata kuliah, Etika dan hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut, Preventive Dentistry, Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, Multi Media Interaktif dalam Kesehatan Gigi dan Mulut, Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut, Dental Asisten, pembimbing Karya Tulis Ilmiah dan Kewirausahaan, Penanggulangan . Tugas tambahan yang pernah dialami pernah menjadi Ibu Asrama, Penjaminan mutu, asesor BKD ,pengelola klinik gigi (owner). Pengalaman Organisasi Profesi Terapis gigi dan mulut sejak tahun 1988 sampai 2024, Wakil ketua Kolegiun TGM , Sekrestaris Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia(APTIKESGI) periode 2018 -2024. Pengalaman menulis buku sejak tahun 1990 sampai sekarang tahun 2024, karya penelitian, publikasi jurnal bereputasi nasional dan internasional, HAKI. Pengabdian Masyarakat, serta keikutsertaan dalam kegiatan Masyarakat lainnya antara lain pengurus masjid, pengurus Ikatan keluarga Gunung Kidul Perantau Th. 20018-2024, Tim gerakan kampung bebas Jentik Kelurahan Pondok Labu Jakarta. Email Penulis: 1966ngatemi@gmail.com, Facebook: @Emiayu Emi

Sinopsis

Bunga Rampai Kesetaraan Gender dalam Pelayanan Kebidanan: Implikasi terhadap Siklus Hidup Perempuan menyajikan jembatan konseptual–kebijakan–praktik untuk memastikan layanan kebidanan yang setara, aman, dan berpusat pada perempuan sejak remaja hingga lansia. Bunga rampai ini menempatkan kesetaraan gender sebagai prasyarat mutu layanan dan pemenuhan hak kesehatan, sekaligus peka terhadap konteks budaya dan dinamika sosial yang memengaruhi keputusan dan akses perempuan pada setiap fase kehidupannya.

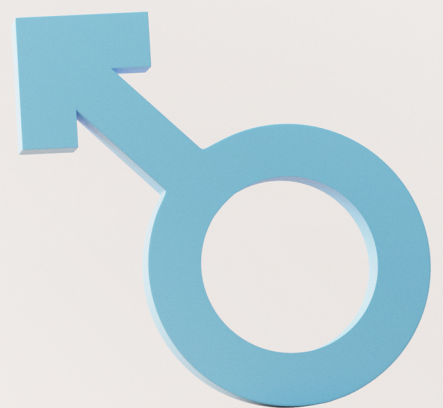
Bab 1 yang ditulis Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb. menguatkan fondasi pemahaman tentang kesetaraan gender pada remaja perempuan. Uraian dimulai dari pendahuluan dan konsep dasar, dilanjutkan dengan karakteristik perkembangan remaja, isu-isu gender yang mereka hadapi, hingga pemetaan hak-hak remaja perempuan. Bab ini menelaah faktor-faktor yang memengaruhi capaian kesetaraan, menawarkan upaya dan strategi yang aplikatif, serta menegaskan peran remaja perempuan sebagai agen perubahan. Pada Bab 2, Bd. Muliana, S.Tr.Keb., M.K.M. memfokuskan kesetaraan dalam kehamilan dan persalinan—menjelaskan konsep, implikasi dalam asuhan kehamilan dan proses persalinan, dampak ketidaksetaraan terhadap keselamatan ibu dan bayi, kerangka kebijakan dan regulasi, strategi serta intervensi, hingga studi kasus dan praktik baik yang dapat direplikasi.

Menutup rangkaian, Bab 3 oleh Ngatemi, S.Si.T., MKM. mengangkat perspektif kesetaraan pada perempuan lansia: perubahan peran sosial, akses terhadap layanan kesehatan, dimensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi, serta tantangan budaya dan stigma yang masih mengemuka. Bab ini merumuskan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah, serta menyoroti peluang inovasi dan teknologi untuk memperkecil kesenjangan. Setiap bab dilengkapi kesimpulan, referensi, dan glosarium, dan buku ditutup dengan profil penulis, sehingga menjadi rujukan praktis bagi pendidik, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mengoperasionalkan kesetaraan gender dalam layanan kebidanan sepanjang siklus hidup perempuan.

Bunga Rampai Kesetaraan Gender dalam Pelayanan Kebidanan: Implikasi terhadap Siklus Hidup Perempuan menyajikan jembatan konseptual–kebijakan–praktik untuk memastikan layanan kebidanan yang setara, aman, dan berpusat pada perempuan sejak remaja hingga lansia. Bunga rampai ini menempatkan kesetaraan gender sebagai prasyarat mutu layanan dan pemenuhan hak kesehatan, sekaligus peka terhadap konteks budaya dan dinamika sosial yang memengaruhi keputusan dan akses perempuan pada setiap fase kehidupannya.

Bab 1 yang ditulis Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb. menguatkan fondasi pemahaman tentang kesetaraan gender pada remaja perempuan. Uraian dimulai dari pendahuluan dan konsep dasar, dilanjutkan dengan karakteristik perkembangan remaja, isu-isu gender yang mereka hadapi, hingga pemetaan hak-hak remaja perempuan. Bab ini menelaah faktor-faktor yang memengaruhi capaian kesetaraan, menawarkan upaya dan strategi yang aplikatif, serta menegaskan peran remaja perempuan sebagai agen perubahan. Pada Bab 2, Bd. Muliana, S.Tr.Keb., M.K.M. memfokuskan kesetaraan dalam kehamilan dan persalinan menjelaskan konsep, implikasi dalam asuhan kehamilan dan proses persalinan, dampak ketidaksetaraan terhadap keselamatan ibu dan bayi, kerangka kebijakan dan regulasi, strategi serta intervensi, hingga studi kasus dan praktik baik yang dapat direplikasi.

Menutup rangkaian, Bab 3 oleh Ngatemi, S.Si.T., MKM. mengangkat perspektif kesetaraan pada perempuan lansia: perubahan peran sosial, akses terhadap layanan kesehatan, dimensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi, serta tantangan budaya dan stigma yang masih mengemuka. Bab ini merumuskan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah, serta menyoroti peluang inovasi dan teknologi untuk memperkecil kesenjangan. Setiap bab dilengkapi kesimpulan, referensi, dan glosarium, dan buku ditutup dengan profil penulis, sehingga menjadi rujukan praktis bagi pendidik, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mengoperasionalkan kesetaraan gender dalam layanan kebidanan sepanjang siklus hidup perempuan.



Penerbit:
PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

